古方医案选編

上集

戴佛延 编著

贈阅
请批评 请交换
政部中医学院图书馆

成都中医学院图书馆藏

样本库

《古方医案选编》

上集

戴佛延

YX/80 b9

北京中医学院图书馆

1021636

成都中医学院

一九七九年三月

前　言

时光好像流水，过得真快。回忆我于1956年奉调来蓉，参加成都中医学院伤寒课的辅导、教学、编写教材等工作，转瞬间已经度过二十二个年头，年龄也随着时间的增长，不觉已虚度六十五个寒暑了。经过这段较长时间的学习和研究，对古典医笈的探讨和古方的运用，深感兴趣。欣逢华主席为首的党中央，英明决策，一举粉碎了祸国殃民的“四人帮”，敬爱的周总理根据毛主席指示，在四届人大宣布的四个现代化的宏伟规划，即将实现，科学的春天，已经到来，举国上下，万象更新。学术领域，百家争鸣，真是一派昌盛繁荣景象，怎不令人精神振奋，干劲倍增。在我院党委领导的关怀和鼓励下，遵照伟大领袖毛主席“古为今用”的教导，草成《古方医案选编》一书，聊供教学、科研和临床工作的参考。由于时间仓卒和认识所限，遗漏和错误的地方一定不少，希望同志们和读者提出宝贵意见，以便作进一步的改正和提高。

戴佛延

一九七八年九月于成都中医学院

几 点 说 明

1、为了在学习古典医笈论中能够紧密结合临床实践，特选录古今医家治验，作《古方医案选编》。（以下简称本编）

2、本编共分上、中、下三集，上集为《伤寒》方医案。中集为《金匮》方医案。下集为《千金》、《外台》方医案。

3、本编用以方统证办法，例如桂枝汤治某某证，麻黄汤治某某证等。与其它医案，以证候分类者不同。

4、本编所选录医案，一概注明出处，以便查阅。

5、原案中所引古典医笈，多未具体指出篇章条文，如在内、难经、伤寒、金匮何篇何条，均一一注明，以便参阅。

6、原案中所引有明显错误处，依经据证酌于改正。

7、本编所引《伤寒论》条文编号，系依据全国中医学院教材重订本1964年版次序排列，与其它注本略有出入，查阅时请依该本为准。

8、本编所收医案，以运用古方为主，时方为辅，既不厚今薄古，也不厚古薄今，力求遵循“古为今用”之旨。

9、本编医案中有原编者按语，概为保存全貌，其有个人点滴体会处，概加“延按”二字以别之。

《古方医案选编》上集

《伤寒论》方医案目录

桂枝汤证案6例……（1）
桂枝汤禁忌证案2例……（4）
桂枝加桂汤证案2例……（6）
桂枝甘草汤证案1例……（7）
桂枝加葛根汤证案1例……（8）
桂枝加朴杏汤证案1例……（8）
桂枝附子汤证案1例……（9）
桂枝加附子汤证案2例……（10）
桂麻各半汤证案1例……（11）
桂枝二麻黄一汤法证案1例……（12）
桂二麻一汤证案1例……（13）
桂枝新加汤增附子证案1例……（14）
桂枝人参汤证案1例……（15）
小建中汤证案1例……（15）
小建中汤加味证案1例……（16）
麻黄汤证案4例……（17）
麻杏石甘汤证案2例……（20）
麻杏石甘汤加味证案2例……（21）
麻附细辛汤证案1例……（22）

麻附细辛、附子泻心汤证案1例……（23）
葛根汤证案1例……（24）
葛根汤加味证案1例……（24）
葛根芩连汤证案1例……（25）
大青龙汤证案1例……（26）
小青龙汤证案3例……（26）
小青龙汤加减证案1例……（28）
小青龙汤加味证案1例……（29）
栀子豉汤证案1例……（30）
栀子生姜豉汤证案1例……（30）
栀子生姜豉汤加味证案1例……（31）
枳实栀豉汤加大黄证案1例……（32）
大陷胸汤证案1例……（32）
小陷胸汤加减证案1例……（33）
大黄黄连泻心汤证案1例……（34）
附子泻心汤证案2例……（35）
半夏泻心汤证案1例……（36）
半夏泻心汤加味证案1例……（37）
黄连汤证案2例……（38）
生姜泻心汤证案2例……（39）
减味旋复代赭石汤证案1例……（41）
五苓散证案3例……（42）
十枣汤证案3例……（44）
十枣汤变汤为丸证案1例……（46）
白虎汤证案2例……（47）

白虎汤加味证案2例……（48）
白虎加人参汤证案5例……（49）
人参白虎汤加减证案1例……（52）
竹叶石羔汤加减证案1例……（53）
调胃承气汤证案1例……（54）
小承气汤证案2例……（55）
大承气汤证案3例……（56）
大承气汤加味证案1例……（57）
桃仁承气汤证案1例……（58）
桃仁承气加味证案2例……（59）
抵当汤证案2例……（60）
抵当丸证案3例……（62）
伤寒治黄三方加味证案1例……（63）
小柴胡汤证案2例……（65）
小柴胡汤加味证案3例……（66）
柴胡桂枝汤加味证案1例……（68）
大柴胡汤证案2例……（69）
大柴胡汤加味证案2例……（70）
柴胡加龙骨牡蛎汤证案1例……（72）
柴胡加龙牡汤加减证案1例……（73）
理中汤证案3例……（74）
理中汤加味证案3例……（77）
理中汤加附子证案1例……（78）
四逆汤证案1例……（81）
四逆加人参汤证案4例……（82）

四逆散证案 1 例……（86）
白通汤证案 1 例……（86）
通脉四逆汤加童便证案 1 例……（87）
茯苓四逆汤证案 1 例……（88）
真武汤证案 2 例……（90）
真武汤加味证案 1 例……（91）
猪肤汤证案 1 例……（92）
黄连阿胶汤证案 2 例……（93）
当归四逆汤证案 2 例……（95）
当归四逆加茱萸汤案 1 例……（96）
干姜苓连人参汤证案 1 例……（96）
麻黄升麻汤证案 2 例……（98）
白头翁汤加味案证 1 例……（100）
加减乌梅丸证案 1 例……（101）
吴茱萸汤证案 1 例……（102）

桂枝汤证案（六例）

1、 太阳中风

许叔微治其乡人吴德甫，得伤寒，身热自汗，恶风，鼻出涕，关以上浮，关以下弱，此桂枝证也。……使服之，一啜而微汗解，翌日诸苦顿除。（录自《本事方》）

延按： 本案先叙证，后述脉，再下诊断并处方，简明扼要。其具体脉证，见于《伤寒论》太阳上篇2、12、13各条。本证既有自汗，如何还须微汗始解呢？因中风证自汗是邪汗，虽汗而不透，出而不畅，证状并不因汗出而缓解，必待服桂枝汤后，荣卫调和，则诸证自除。

2、太阳中风

许叔微治里闾张太医家一女子，病伤寒，发热，恶风，自汗，脉浮而弱。许曰：当服桂枝，（当为桂枝汤），彼云：家有自合者，许令三啜之，而病不除，予询其药中用肉桂耳。许自制以桂枝汤，一啜而解。论曰：仲景论用桂枝者，盖取桂枝轻薄者耳，非肉桂之肉厚也。盖肉桂厚实，治五脏用之，取其镇重。桂枝清轻，治伤寒用之，取其发散。今人一例，是以无功。（录自《伤寒论类方汇参，桂枝汤案例》）

延按： 本案既具桂枝汤典型证状，用本方何以不效？

通过详询，始知方中主药桂枝，是代以肉桂，以致三啜而病不除，后改用桂枝，即一啜而解。案中说明桂枝与肉桂功能，值得注意。从这个案例看来，充分说明药物的作用各有其特性，在临床应用时是应该仔细考虑的。

3、表未解似里实

儒者吴君明，伤寒六日，谵语狂笑，头痛有汗，大便不通，小便自利。众议承气汤下之，士材诊其脉浮而大。因思仲景曰："伤寒不大便六七日，头痛有热，小便清者，知不在里，仍在表也。"方今仲冬，宜与桂枝汤。众皆咋舌，以谵狂为阳盛，桂枝入口必毙矣。李曰：汗多神昏，故发谵妄，虽不大便，腹无所苦，和其荣卫，必自愈耳。遂违众用之。及夜而笑语皆止，明日大便自通……。（录自《古今医案按，李士材案》）

延按： 本案引仲景语，见《伤寒论，太阳中篇》56条。此证用桂枝汤的着眼点，在于外证虽有谵语狂笑，大便不通的假实证，但无潮热腹满拒按脉实可攻的依据，而有头痛有汗，脉浮大的表证表脉可凭，故一用桂枝汤而谵语止，大便通，正所谓"外疏通，内畅遂也"。辨证之精，足资启发。

4、误下表邪尚在

张隐庵治一少年，伤寒三四日，头痛发热，胸痛不可忍。病家曰：三日前因食面而致病。张曰：不然，面饭粮食，何日不食，盖因外感风寒，以致内停饮食，非因食面而

为头痛发热也。故凡停食感寒，只宜解表，不可推食，如里气一松，外邪即陷入矣。且食停于内，在胸下胃脘间，按之而痛；今胸上痛不可按，此必误下而成结胸。病家云：昨延某师，告以食而，故用消食之药，以致胸中大痛。因诊其外证尚在，仍用桂枝汤加减，一服而愈。

按： 从此案可以充分说明表证误下之害。但误下之后，表邪尚未全陷，还有外出之机的，即宜乘势使用汗法，使邪仍从汗解，否则错过时机，邪气内陷，待结胸、下利、痞证等变证出现之后，再行救误，那就更增麻烦。此案之治病用药，目光敏锐，当机立断，是非常重要的。（录自《伤寒论译释》）

延按： 凡外感风寒致内停饮食，在表邪未解，里证不急的情况下，就应当先解表，表解而里自和，此伤寒通例。

5、太阳中风

头项强痛而恶寒，脉缓有汗，太阳中风，主以桂枝汤。

桂枝9克　白芍6克　炙草6克　生姜9克　大枣二枚

水五杯，煮二杯，第一杯服后，即食稀热粥，令微汗佳，有汗，二杯不必食粥，无汗仍然。（录自伤寒论译释·吴鞠通医案）

延按： 风寒之邪，本相因而至，故不应截然划分，所以《伤寒论》太阳上篇12条有"啬啬恶寒，淅淅恶风"之语，本案不言恶风而言恶寒，当本此义。至桂枝汤本治有汗的中风证，其病是有汗出证的，此案后有"无汗仍然"句。揆其意，系指桂枝汤服后药力未达，未能漐漐微似汗出而言，并

非本证无汗。案中既具备了桂枝汤典型脉证，故用桂枝汤原方不增减，煮服亦悉遵仲景，可谓学古有获。

6、病常自汗出

一商人自汗证，达半年之久，延医服止涩收敛药如龙牡之类，约数十帖之多，毫无寸进，请中医王子政治疗，询知病者无发热恶风证状，汗出不温，精神觉得疲倦，脉象弱而不振，温剂收涩药已遍服无效。乃予桂枝汤，服五帖而愈。

按： 桂枝汤调和荣卫，具发汗止汗之功，观此案可证。（录自《伤寒论译释》）

延按： 余在蓉曾治一病员魏某，系绵阳修理收音机工人，年廿余，体瘦弱，面色青白，四肢欠温，夏月犹著毛线衣，诊之，脉缓弱，稍动即易出汗，屡感冒，常服西药并打针无效，余处以桂枝汤合玉屏风散，服廿余剂治愈，即师此案意立法。

桂枝汤禁忌证案（二例）

1、酒客患中风

富安钟表商人，殷利泉，患头疼发热，汗出恶风，脉浮之表证。同时其人嗜酒达数十年之久，每餐必饮，生平最不喜欢甜食。医按太阳中风证治疗，而给以桂枝汤与服，服后呕吐不已，表邪未解，反增喉痛咽塞，中医王子政以葛根芩

连汤加减，服三剂，咽肿消而身热退矣。

按： 此案嗜酒数十年，且平素不喜甜食，则湿热内盛可知。（录自《伤寒论译释》）

延按： 本案所述病情与《伤寒论，太阳上篇》18条相符。喻嘉言说："酒客平素湿与热搏结胸中。才挟外邪，必增满逆，所以辛甘之法，遇此辈即不可用。则用辛凉以彻其热，辛苦以消其满，自不待言"。观案中所出治疗方剂，有解表清里之功，所以获效。至加减之法，《世补斋谓》："芎、芷、羌、独、荆芥、藁本、蔓京、卜荷、桑叶、藿香、香薷、赤芍、丹皮、黑栀等药，皆可随证加入，"特录出以供临床参考。

2、内热素盛失血

周，三四，屡屡失血，饮食如故，形瘦面赤，禀质木火，阴不配阳。据说服桂枝汤治外感，即得此恙。……。徐灵胎批云："风嗽夹火者，服桂枝汤必吐血，百试百验"。

按： 叶氏之医案，及徐氏之批语，可作为本案经文《伤寒论、太阳上篇》20条有力的证实。（录自伤寒论译释临证指南医案）

延按： 《伤寒论注释要编》（孙纯一编著）于本条下注云："服桂枝汤，吐脓血者，可用一味茅根汤，或用阿胶鸡子黄汤……，至于日后吐脓血者，宜察其在肺在胃，依肺痈胃痈之法而治之。"可供临床参考。

桂枝加桂汤证案（二例）

奔　　豚

例一：湖北张某，为书店帮伙，一日延诊，云近日得异疾，时有气痛，自脐下少腹起，渐冲痛到心，顷之止，已而复作，夜间尤甚，请医不能治，已一月有奇。审视舌苔白滑，脉沉迟，即与桂枝加桂汤，一剂知，二剂愈。

例二：周右，住浦东，初诊，气从少腹上冲心，一日四五度发，发则白津出，此作奔豚论。

肉桂心8克　川桂枝　大白芍各6克　炙甘草6克　生姜三片　大红枣八枚

二诊：投桂枝增桂汤后，气上冲减为日二三度发，白津之出亦渐稀，下泻矢气，此为邪之去路，佳。

按：　以上两条之奔豚证状，均较典型，投以桂枝加桂汤后，都能迅速收到效果，足见运用经方，只要方证相对，疗效是确实可靠的。《金匮》亦有奔豚桂枝加桂汤证，证状大体相同，不过彼之病因为从惊恐而来，此之病因为针后受寒，但是其机转总不外心阳不足，下焦寒气上逆，与《金匮》奔豚汤证之气从少腹上冲心应有鉴别。一案中之舌苔白滑，脉沉迟。二案中之发则白津出（即发作时口中有清水流出），均为应用本方之重要眼目。（录自伤寒论译释·遯园医案和《经方实验录、姜佐景医案》）

延按：　以上两案，桂枝加桂汤中之桂，均应以加肉桂为是，因两案均无表证，故不用桂枝，有阴寒水气之里证，

故须加肉桂也。参考桂枝汤证案二许叔微之分析，更加明确。

桂枝甘草汤证案（一例）

汗多义手冒心

马元仪治沈康生夫人，病经一月，两脉浮虚，自汗恶风，此卫虚而阳弱也。与黄芪建中汤一剂汗遂止。夫人身之表，卫气主之，所以"温分肉，肥腠理，司开合者"①，皆此卫气之用。故内经曰："阳者卫外而为固也"②。今卫气一虚，则分肉不温，腠理不密，周身毛窍有开无合，由是风之外入，汗之内外，其孰从而拒之？故用黄芪建中汤以建立中气，而温卫实表也。越一日病者义手自冒心间，脉之虚濡特甚，此汗出过多而心阳受伤也。仲景云："发汗过多，病人义手自冒心，心下悸者，桂枝甘草汤主之"。③与一剂良已。

按： ①《灵枢·本脏篇》

②《素问·生气通天论》

③ 《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》64条。

按： 从本条的效果上来看，桂枝甘草汤治汗后阳虚心悸的疗效是非常确实可靠的。脉虚濡与病经一月之自汗恶风，都是本案的辨证眼目。（录自《伤寒论译释》）

延按： 本案前一阶段证状，得力于《金匮·血痹虚劳病脉证并治第六》之黄芪建中汤，后一阶段，才收效于桂枝甘草汤。两方的作用，均不能忽视，如在方中再加枣仁、桂

仁、地黄、枸杞、龙眼、红枣、小麦等以增强疗效、似更佳。

桂枝加葛根汤证案（一例）

太阳汗出恶风背强

庚戌，建康徐南强，得伤寒，背强，汗出，恶风，予曰：桂枝加葛根汤证。病家曰：他医用此方，尽二剂如旧，汗出愈加。予曰……是方有麻黄，服则愈见汗多……止于桂枝加葛根汤也（注）。予令服之，微汗而解。（《录自伤寒九十论》）

注：《伤寒论·太阳篇上》14条。

延按： 考原方中有麻黄，林亿校正云："恐是桂枝中但加葛根耳"。今观许案说明并通过临床实践，其应去麻黄绝无可疑，足见原方之错简，林亿校正之可信。

桂枝加朴杏汤证案（一例）

伤寒误下微喘

一武官为寇执，置舟中艨板，数日得脱，乘饥恣食，良久解衣捉虱，次日遂伤寒，自汗而瞩不利。一医作伤食而下之，一医作解衣中邪而汗之。杂治数日，渐觉昏困，上喘息高。许诊之曰："太阳下之，表未解，微喘者，桂枝加厚朴杏仁汤"（注），此仲景法也。指令医者治此药，一啜喘定，再啜热缓微汗，至晚身凉而脉已和矣。

注：《伤寒论·太阳篇上》43条。

按： 本条证状病因与古方吻合，所以即用原方，并无加减，效果卓著，从而可证仲景立方的精纯。（录自伤寒论译释·本事方）

延按： 考伤寒论用本方，一为43条，一为19条，前者系误下致喘，后者系新感引发宿疾致喘。本案病情与43条相符，因误治后上喘息高，表仍未解，故用杜杏汤解肌，加厚朴、杏仁下气定喘。

桂枝附子汤证案（一例）

伤寒变痹

张幼文，32岁。素因多湿，偶感风寒，发热恶寒，一身手足尽痛，不能自转侧，脉浮大而紧，风为阳邪，故脉浮大主病进，紧主寒凝，脉证合参，风寒湿三气合而成痹，桂枝附子汤主之。方中桂、附辛热散寒，草、枣奠安中土，生姜利诸气，宣通十二经络，使风寒湿若于肌表而作痛者，一并廓清矣。

处方： 桂枝12克　附子4.5克　甘草6克　大枣六枚
生姜9克

一日二服，三日举动如常，继服平调之剂愈。

何廉臣按：伤寒变痹，必挟风湿。《伤寒论》曰："伤寒八九日风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。"今有是证则用是药，确得仲景心法。（录自《全国名医验案类编·曾月根医案》）

延按： 何按所引见《伤寒论·太阳篇下》179条，所

述主要证状，基本相符，惟脉象有出入，彼系浮虚而涩，此为浮大而紧。余意度之，伤寒八九日，风湿相搏，病程较长，故脉显虚象，此系偶感风寒，素因多湿，病程较短，故显寒凝之脉也。

桂枝加附子汤证案（二例）

1、伤寒过汗阳虚液脱

一人太阳症，因发汗不止，恶风，小便数，脚挛急，屈而不伸，脉浮而大。许曰：此证在仲景方中有两条，大同小异，一则"太阳病，发汗，遂漏不止，恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸。"一则"伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急。"一属漏风小便难，一属有汗小便数，不可混治。此当用桂枝加附子汤，三啜而汗止，佐以芍药甘草汤，足便得伸。（录自古今医案按《本事方》）

延按： 许案引述两条，见《伤寒论·太阳篇七》21、29条条文，用第一方以止其汗而救液，用第二方以治其脚挛急而养阴柔筋，其分析病情，处方用药，均甚恰当。

2、太阳伤风救误

熊继先乃郎，半岁。肌肤娇嫩，阳气素微，患伤风、鼻塞咳嗽，医以二陈、苏、防之属，因而得汗，即至嗽声不出，气急神扬，尚以不嗽为效，……又误进苏子、枳壳之属，下咽未久，忽然目珠上瞪，四肢抽掣，小水短少，又误进钲惊

丸，……悬余治之，遂疏桂枝附子汤与服（按：当系桂枝加附子汤）（注），尔时变证愈出，忙煎灌之，一剂而风痉自止，再剂而诸恙悉痊。……盖此儿阳气素微，汗之有亡阳之变，夫汗为心之液，四肢为诸阳之本，小便为阳气之化，误发其汗，阳越于表，津竭于里，营卫将离，是皆太阳阳亡之象，亦诚危矣。（录自《尚映庐医案》）

注《伤寒论·太阳篇上21条，

延按： 本案借用《伤寒论》治漏汗之桂枝加附子汤来治疗小儿风痉，获得良好效果，可谓善用古方。至案中指本证为太阳亡阳，似尚未到此严重阶段，如果为亡阳证，当汗出如珠，手足厥逆，下利清谷，非此方所能治，当用四逆汤挽救。此案谓为阳虚脱液，较为妥当。

桂枝麻黄各半汤证案（一例）

外感表邪里气不畅

许叔微治一人，病伤寒身热头痛无汗，大便不通，已四五日。予讯之，见医者治大黄朴硝等欲下之。予曰：子姑少待，予为视之，脉浮缓，卧密室中，自称甚恶风，许曰：表证如此，虽大便不通数日，腹又不胀，别无所苦，何遽便下，大抵仲景法，须表证罢，方可下，不尔，邪乘虚入，不为结胸，必为热利也，作桂麻各半汤与之，（注）继之以小柴胡汤，漐漐汗出，大便亦通而解。

注《伤寒论·太阳篇上》23条，

按： 身热头痛，无汗，为麻黄汤证，脉浮缓恶风，为桂

枝汤证。此时单用一方均不适合，而桂麻各半汤，却能两顾，所以此条之证状，虽不如本条所述的典型，但服后即能取效，于此也可以体会到辨证用药的重要性。（录自伤寒论译释《本事方》）

延按： 本案继用小柴胡汤之意义，见《伤寒论·阳明病篇》233条，所谓"上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。"主要从宣达表里上下气机处着眼。

桂枝二麻黄一汤法证案（一例）

阳虚体质感受风寒

头痛恶寒，脉紧，言蹇，肢冷，舌色淡，太阳中风，虽系春季，天气早间阴晦，雨气甚寒，以桂枝二麻黄一法。

去节麻黄9克　桂枝18克　炙甘草9克　杏仁15克　生姜六片　大枣二枚

煮三杯，得微汗，再服，不汗促投其间。

按： 头痛恶寒脉紧是麻黄汤证，肢冷舌色淡，显系阳虚体质，表证虽急，但又不宜峻发，吴氏用方之目的，不外以桂枝汤顾护不足之阳气，麻黄汤疏散表邪，两者相互为用，于此可以看出，吴氏运用古方，是非常活泼和富有创造性的。（录自伤寒论译释《吴鞠通医案》）

延按： 本案所用方剂剂量，桂枝多于麻黄一倍，符合桂二麻一法。不用芍药，恐因肢冷舌淡，兼天阴晦，雨气甚寒，呈显一派阳气不足的现象，不欲芍药之阴柔滞邪耳。因

无芍药，故云某法而不云某汤。

桂二麻一汤证案（一例）

太阳表邪未解

李某，男，49岁。恶寒颤慄，发热，热后汗出身凉，日发一次，连续三日。伴见头痛，肢楚，腰疼，咳嗽痰少，食欲不振，二便自调。脉浮紧，舌苔白厚而滑。治宜辛温解表轻剂，与桂枝二麻黄一汤。

处方： 桂枝 白芍各9克 杏仁 甘草各6克 生姜6克 麻黄1.5克 大枣三枚

案后俞氏自注云："恶寒发热，头痛肢楚，脉浮紧，均属太阳表证。病连续三日，日发一次，但无胸胁苦满，心烦喜呕，知未入少阳；二便自调，知未传阳明。邪在太阳之表，本汗出后即安，今仍持续发作者，可知邪势尚盛。其脉浮紧，本当与麻黄汤，但已出汗，又未便峻剂发表，故取桂二麻一汤，以桂枝汤解肌，佐麻黄小取微汗，杏仁宣肺。服药后，寒热除，诸证悉减。现惟心悸少气，腹微痛喜按，大便正常，脉转弦缓，系外邪初解，荣血不足，气滞使然，与小建中汤一剂遂安。(录自《伤寒论汇要分析，俞长荣医案》)

延按： 本证始终留连在太阳经，并无传入少阳或阳明的征兆，故治法如此，但表虽未解，因汗出之故，恐其卫外不固，故用桂二麻一汤轻剂解表。迨表解后，又现中虚，转手即与建中，先表后里，治法井然。

桂枝新加汤增附子证案（一例）

阳虚 感 冒

朱君，中学教员。体羸弱，素有遗精病，又不自爱惜，喜酒多嗜好，复多斲丧。平日恶寒特甚，少劳即喘促气上，其阳气虚微肾元亏损也明甚。1947年冬赴席邻村，醉酒饱食，深夜始归，不免风寒浸袭。次日感觉不适，不恶寒，微热汗出，身胀，头隐痛。自服葱豉生姜汤，病未除，精神呈不振，口淡不思食，切脉微细乏力。参之前证，则属阳虚感冒，极似伤寒太阳少阴两感证。但治两感之麻附细辛，麻附甘草汤两方，殊不宜阳虚有汗之本证。当改用桂枝新加汤增附子为治。

处方： 党参15克 桂枝 芍药 炙草各9克 生姜4.5克 大枣五枚 附子9克

嘱服三帖。

复诊：诸证悉已，食亦略思，但神疲脉微，阳气未复，犹宜温补，处以附子汤加巴戟、枸杞、鹿胶、芦巴补肾诸品，调理善后。（录自赵守真治验回忆录）

延按： 阳虚感冒，用桂枝新加汤增附子以治，较之用再造散，乡苏饮等方自胜一筹，善后处以温润强壮肾阳之品，用意亦精当可法。

桂枝人参汤证案（一例）

外热协内寒下利

刘君，痢病复作，投当归银花汤，另送伊家制痢疾散茶二包，病虽愈，惟便后白色未减，心下痞硬，身热不退。愚思仲景曰："太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞鞕，表里不解者，桂枝人参汤主之"(注)。遂书此以服，大效，后因至衢洲取帐目，途中饮食不洁，寒暑失宜，病复大作，遂将原方续服三剂愈。

《伤寒论·太阳篇下》158条。

按： 此案之要点有三，一为便后白色未减，是里虚寒之证，一为心下痞鞕，亦属虚痞范围，一为身热不退，是表邪未尽所致，三者具备，是为用本方之的证，但此方药性辛温，必须无口渴脉数等热象才能应用。（录自伤寒论译释《中医杂志第20期谢安之医案》）

延按： 本方即理中加桂枝，不以此名方，而曰桂枝人参汤者，意在治里虚寒下利而兼解表也，本案所述证状，与168条基本符合，故用之有效。

小建中汤证案（一例）

中阳不足腹痛

王右，腹痛喜按，痛时自觉有寒气自上下迫，脉虚弦，微恶寒，此为肝乘脾，小建中汤主之。

按： 曹案中的辨证要点，为脉虚弦三字。弦为阴脉，虚弦而又微恶寒，是中阳不足，阴寒气盛，肝木乘脾的现象；故以小建中汤温健中阳，甘缓止痛。

录自（伤寒论译释《经方实验录·曹颖甫医案》）

延按； 小建中汤是桂枝汤加重芍药剂量再加胶饴而成，为温养中气之剂。本案因阳虚不能卫外，故微恶寒，阳虚则阴盛，故自觉寒气自下上迫，腹痛喜按，属虚无疑，但病势不甚严重，故用本方小小建立其中气足矣。

小建中汤加味证案（一例）

伤寒尺脉迟弱

许学士治乡人邱生，病伤寒发热，头痛烦渴，脉虽浮数而无力，尺以下迟而弱。许曰：虽麻黄证，而尺迟弱。仲景曰："尺中迟者，荣气不足"，未可发汗，用建中汤加当归、黄芪，翌日脉尚尔，其家索发汗药，言几不逊，许忍之，只用建中调营而已，至五日，尺部方应，遂投麻黄汤二服，发狂须臾，稍定略睡，已得汗矣。信乎医者当察其表里虚实，待其时日，若不循次第，取效暂时，亏损五脏，以促寿限，何足贵也。（录自古今医案按《本事方》）

延按： 此证着眼点，在脉浮弱无力，尺脉迟而弱，所以不能轻率发汗。至引述仲景语，与《伤寒论·太阳篇中》50条相符，但未出治法与方剂，本案先用归芪建中顾其里虚，后用麻黄汤治其表实，所以获愈。

麻黄汤证案（四例）

1、伤寒脉浮紧不发汗致衄

陶尚文治一人，伤寒四五日，吐血不止，医以犀角地黄汤等治而反剧。陶切其脉浮紧而数，若不汗出，邪何由解，遂用麻黄汤，一服汗出而愈。

瑾按：久衄之家，亡血已多，故不可汗，今缘当汗不汗，热毒蕴结而成吐血，当分其治波乃愈。

按：伤寒脉浮紧而吐血，这种吐血与本条《伤寒论·太阳篇中》55条的衄血同样是由于失表所致。前医用犀角地黄汤，不但不能取效，阴寒之药，反使表邪更加锢闭，而吐血之势必然加甚。陶氏根据本条的原则，大胆的运用了麻黄汤，因而取得了效果。（录自伤寒论译释《名医类案》）

延按：本证得伤寒仅四五天，其在太阳表分可知，不用火郁发之之法，而用寒凉抑遏，显违仲景病在表应先解表的原则，所以无效。陶氏是根据这一理论来治疗的。但张锡纯氏所著《衷中参西录·医论》麻黄汤证下谓："麻黄汤证，若遇其人素有吐血病者，虽时已愈，仍宜去桂枝代以防风（吐血证最忌桂枝）再加生白芍。"特录之供临床参考。

2、寒闭失音

汪之常养鸭为业。残冬寒风凛冽，雨雪交加，整天放鸭奔走道途，不胜其劳。某晚归时，感觉不适，饮冷茶一大

盅。午夜恶寒发热，咳嗽声嘶，既而语言失音。曾服姜汤冲杉木炭末数盅，声哑如故。据其父代述失音原委，因知寒袭肺金，闭塞宣窍，故咳嗽声哑。按脉浮紧，舌上无苔，身疼无汗，乃太阳表实证。其声暗是由形寒饮冷伤肺，是金实不鸣之故。治宜开毛窍宣肺气，疏与麻黄汤。

处方：麻黄9克　桂枝　杏仁各6克　甘草3克

服后，温复取汗，易衣二次，翌日外邪解、声音略扬，咳仍有痰，胸微胀。又于前方去桂枝，减麻黄为4.5克，加贝母、桔梗各6克，白前3克，细辛1.5克，以温肺化痰。续进二帖，遂不咳，声音复常。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本案通过问诊和切脉，知其得病原委，又表现出典型的太阳表实证，麻黄汤用得非常恰当，至表解后，方去桂枝，减麻黄量，又加桔、贝、甘、辛等药者，恐寒邪郁久化热，故于辛开中佐润肺祛痰之品以善其后。

3、太阳伤寒

陈△△，年六旬，小贸营生，日在风霜雨雪中行走，冬月感寒……病人蒙头而卧，自云头痛甚不能转侧，足筋抽痛，不能履地，稍移动，则痛欲死，发热无汗，脉紧有力，乃太阳伤寒证也。即以麻黄汤取汗，果微汗出而头足痛减，稍能进粥食。以其元气素亏，继进桂枝新加汤四剂，痛减，食更增，调理月余，始能外贸。（录自湖南中医医案选辑，龚亨安）

延按：本案从其职业，时令，脉证观察，纯属太阳伤

寒，用麻黄汤是恰当的。但考虑其年六旬，元气素亏。故服药后只取微汗解病，如大汗恐有亡阳之变。至善后方采用桂枝新加汤，是解表兼顾正气之法。

4、太阳伤寒

例一：范左，伤寒六七日，形寒发热，无汗而喘，头项腰脊强痛，两脉浮紧，为不传也，麻黄汤主之。

麻黄　桂枝各3克　杏仁9克　甘草2.5克

例二：黄汉栋，夜行风雪中，冒寒，因而恶寒，时欲呕，脉浮紧，宜麻黄汤。

生麻黄　桂枝各9克　光杏仁9克　生甘草4.5克

例三，俞右，伤寒，头项强痛，恶寒，时欲呕，脉紧，宜麻黄汤。

麻黄　桂枝各15克　杏仁　生甘草各9克

按： 上述之案，其证状都比较典型，一案中的无汗而喘，头项腰脊强痛，与35条的“身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者”符合。二案中的时欲呕，脉浮紧，三案中的头项强痛，时欲呕，与第3条“体痛呕逆，脉阴阳俱紧者”符合，由此可见，脉浮紧无汗，是麻黄汤证的必具脉证，但喘与呕，则不一定同时并见。大致寒邪郁肺的多喘，寒邪犯胃的多呕，但致喘致呕的原因还是一个，即寒束肌表。治病必求其本，用麻黄汤开腠发汗，主证一除，伴见之证状亦皆随之而去。（录自伤寒论译释《经方实验录·曹颖甫医案》）

延按： 以上三案，均属太阳伤寒证，均用麻黄汤，但剂

量不同，一案最轻，二案较重，三案更重。揆其故，当系根据病人的体质强弱，感寒的轻重，而斟酌其方中剂量也。

麻杏石甘汤证案（二例）

1、麻闭急证

肖翁三郎心成，幼时出麻，冒风隐闭，喘促烦躁，鼻扇目合，肌肤枯涩，不啼不食，投药莫应，势已濒危。谓曰：此麻闭急证，药非精锐，莫能挽救，方疏麻杏石甘汤与之，一服肤润麻渐发出，再服麻出如痧，神爽躁安，目开喘定，继用泻白散清肺解毒，复用养阴退阳之剂而愈。（录自程杏轩医案初集）

延按：本案后程氏自注谓："予治麻闭危候，每用此方获效，盖麻出于肺，闭则火毒内攻，多致喘闷而殆。此方麻黄发肺邪，杏仁下肺气，甘草缓肺急，石膏清肺热，药简功专，所以效速。"诚属经验之谈。《伤寒论类方汇参》亦云："痧疹发于暴寒之时，肌表头面不透，是外袭寒邪内蕴伏邪，宜两解肺胃之邪，用此汤加桔梗、薄荷、射干、牛蒡主之。"录此存参。

2、热邪内壅肺气闭阻

邱某，高热不退，咳嗽频剧，呼吸喘促，胸膈疼痛，痰中夹有浅褐色血液，间有谵妄如见鬼状，患者体温40度，脉象洪大。此证高热喘促，是热邪迫肺，痰中夹血，血色带

渴，胸膈疼痛，均系内热壅盛肺气闭塞之故。正宜麻杏宣肺气，疏肺邪，石膏清里热，甘草和中缓急。方用：石膏75克 麻黄、杏仁各9克 甘草6克，水煎，分三次服，每隔一小时服一次。服完一剂后，证状减约十之七八。后分别用蒌贝温胆汤，生脉散合泻白散两剂，恢复健康。（录自伤寒论汇要分析·俞长荣医案）

延按：本证如见痰中夹血，不详询致病原因，泛投一般清热凉血止血套药，很难见效，因痰血系由热邪内壅，肺气闭阻所引起，必须以宣肺清胃降逆和中之剂始能取效。至善后两方，一清化痰热，一滋养肺阴肃清余热，治法井然。

麻杏石甘汤加味案（二例）

寒邪郁热

例一：钟右，病伤寒七日，发热无汗，微恶寒，一身尽疼，咯痰不畅，肺气闭塞使然也。痰色黄，中已化热，宜麻杏石甘汤加浮萍。

例二：朱锡基家一婢女，病发热，请予诊治，予轻剂透发，次日热更甚，未见疹点，续与透发，三日病加剧……细察病者痧已发而不畅，咽喉肿痛有白腐意，喘声大作，呼吸困难不堪，咯痰不出，身热胸闷，目不能张视，烦躁不得眠，此实烂喉痧之危候，当与麻杏石甘汤略加芦根、竹茹、蝉衣、蚤休等透发清热化痰之品，服后即得安睡，痧齐发而明，喉痛渐除，续与调理三日而愈。

按：曹案用本方之关键，在于痰色黄，盖痰黄是里热之

证；姜案用本方之关键，在于痧已发而不畅，且呼吸困难。两案之病情虽迥异，但其为肺气壅遏不利则无二致。麻杏石甘汤亦为辛凉甘润之法，其宣肺气，清肺热之功非他方所能及，故能应手取效。（录自伤寒论译释《经方实验录·一、曹颖甫、二、姜佐景医案》）

延按：曹案加浮萍，系师黄坤载法。但本证既有痰色黄，咯痰不畅，似应于本方再加黄芩、栝蒌、竹茹、石苇、橘红等，以增强清热豁痰之力。姜案借用本方以治喉肿白腐，系师皇汉医学及恽铁樵法。于于此方加入宣透清化药品，收效更佳，真得古方化裁之妙。

麻附细辛汤证案（一例）

少阴伤寒

蒋尚宾妻，年62岁。严冬之时，肾阳衰弱，不能御寒，致寒深入骨髓，头痛腰疼，身发热，恶寒甚剧，虽厚衣重被，其寒不减，舌苔黑润，脉沉细而紧，用麻附细辛汤以温下散寒，一剂汗出至足，诸证即愈。

何廉臣按：少阴伤寒，始得病即脉沉发热，略一蹉跎，势必至吐利厥逆，故乘其外有发热，一用麻黄治其外，一用附子治其内，然必佐细辛，从阴精中提出寒邪，使寒在骨髓者，直从外解。（录自全国名医验案类编·王经邦医案）

延按：本案不认为太阳伤寒麻黄汤证而认为少阴伤寒麻附细辛汤证者，其辨证要点在于舌和脉上。寒邪在表，舌必白润，脉必浮紧，此寒邪在里，故舌黑润，脉沉细而紧，为

少阴邪从寒化兼表证也。

忆余解放后，在家乡开业时，曾治一青年，姚某，廿余岁，新婚，卖蔬菜业，冬月感冒，而赤发热，足冷无汗，脉浮大重按无力，其人面白体丰，阳虚体征，为肾阳虚兼外感，拟麻附细辛汤，一剂，微汗病解，继以真武汤，附子汤善其后，全愈。

麻附细辛、附子泻心汤证案（一例）

两感伤寒

喻嘉言治金鉴春温已二旬外，壮热不退，谵语无伦，皮肤枯燥，胸膛板结，舌卷唇焦，身蹉足冷，二便略通，半渴不渴，面上一团黑滞，从前汗下和温之法，历试不效。喻曰：此证与两感伤寒无异，内经原谓六日死，因春温证不传经，故虽邪气留连不退，犹可多延几日，待元气竭绝乃死，观其阴证阳证两下混在一区，治阳则碍阴，治阴则碍阳，与两感病情符合，仲景原无治法，惟论序有发表攻里，本自不同之说，即师其意，以麻黄附子细辛两解在表阴阳之邪，果然皮间透汗而热全清，再以附子泻心汤两解在里阴阳之邪，果然胸前柔和，人事明了，诸证俱退，次日即索粥，以后竟不需药，只此二剂，而起一生于九死，快哉。（录自古今医案按）

延按：此证壮热不退，由于无汗之故，是表气不通，故用麻附细辛，皮间透汗而热退；胸膛板结，是里气不通，故用附子泻心，则胸前柔和，立法巧故见效速也。

葛根汤证案（一例）

项背部痠痛

陈××，男，43岁，业商。

颈项肩背痠痛，拘急不能转侧，病起仓卒，实证为多。

处方：葛根6克　麻黄2克　桂枝2克　白芍9克　甘草5克　生姜9克　大枣6枚

一剂全愈，为巩固疗效计，续服一剂。（录自浙江中医杂志1958年总16期陶春岩　沐明）

按：本证病起于暴，无虚衰的证状，所以断为实证，故径用原方，不必增减药味。但用药剂量，似嫌过轻，在江浙地区，自然合适，如在高寒地带，体质较强病势又顽固的，则宜适当加重其剂量，则疗效更佳。

葛根汤加味证案（一例）

项背部痠痛

陈××，男，37岁，业农。

初诊：五月间起病，肩项背部痠痛，卧床不起，不能转动，经针灸治疗，病去其半，未继续治疗。当时肩背连及腰脊痠痛沉坠，不能俯仰自如，面黄形瘦，周身无力，脉细，苔白薄，无寒热。

处方：葛根6克　麻黄2克　桂枝2克　白芍9克　甘草5克　生姜9克　大枣5枚（二剂）

次诊：痠痛已减，腰背拘急亦舒，仍宗前原方加味。

处方：葛根6克　麻黄2克　桂枝2克　白芍9克　苍术5克　附片2克　生姜9克　大枣5枚（二剂）。

三诊：痛阔过半，转侧俯仰自如。

处方：麻黄2克　桂枝2克　白芍9克　甘草5克　大枣5枚　附片2克　独活6克　苍术5克　生姜9克（二剂）

服后全愈，现已参加劳动。

录自（浙江中医杂志，1958年总16期陶春岩　沐明）

延按：本证痠痛而兼沉坠，上至肩项，下连腰脊，时间迁延较久，身体偏衰，兼夹有湿滞。所以在二三诊时于本方内再加苍术、附片、茅术、独活等，以增强温阳燥湿疏通经络之功。

葛根黄芩黄连汤证案（一例）

小儿挟热下利

吴启明子，周岁。发热呕吐，泄泻并迫，烦躁不能少睡，大渴饮水不休。医者误为脾胃不足之呕，虚阳外发之热，津液下陷之渴，与七味白术散一服，遂至两目上吊，角弓反张，肢体痉强，牙紧气促，唇口齿舌干燥而不可解。余知此症乃痰邪传胃，未经清解，以致协热下利，宜以葛根芩连汤一服，病气大退。再以小柴胡汤去半夏、加花粉，二剂而安。（录自谢映庐医案）

延按：案后谢氏自注谓："哑科之病，人皆详其外而略

其内，所以头疼身痛，胸中膨满，小便涩痛，大便热泄，人所不知，而医者又不详为谛审，徒执白术散为渴泻圣药一语，致令疫邪愈炽，高热窜狂，小儿筋骨柔脆，极为难治，欲其不筋脉牵引，变为痉证，其可得乎。”对于表邪未解，挟里热下利之病，医者认实作虚，误用温燥缓补变痉之理，分析极明。治法先用葛根芩连汤，解表清里，继用小柴胡汤，和解表里，去半夏、加花粉以避燥生津，收愈。

大青龙汤证案（一例）

太阳表寒里热烦躁

何保义从王太尉军中，得伤寒，脉浮涩而紧。许叔微曰：“若头痛，发热，恶风无汗，则麻黄证也，烦躁，则青龙汤证也。”何曰：今烦躁甚。投以大青龙汤，三投汗解。

按：不汗出而烦躁，为大青龙汤的证，本案使用大青龙汤得效，就是以这一标的为依据，于此益信仲景之书为临床实践的总结，所以历验不爽。（录自伤寒论译释《名医类案》）

延按：本案典型脉证见《伤寒论·太阳篇中》38条，为寒闭于表，热郁于里所致。其方即麻黄汤加石膏、姜、枣而成，许案叙述病情，简而得要，可资取则。

小青龙汤证案（三例）

外感风寒内挟水气

例一：张志明先生，初诊：暑天多水浴，因而致咳，诸

药无效，遇寒则增剧，此为心下有水气，小青龙汤主之。（录自伤寒论译释《经方实验录·姜佐景医案》）

例二：刘骋贤孙六岁，住刘行乡南潘泾宅，十一月下旬，夜间随祖父戽水捕鱼，感冒风寒，咳嗽痰粘，前医投方旋复代赭汤，咳嗽陡止，声音嘶哑，涎壅痰鸣，气急鼻掀，肩息胸高，烦躁不安，大小便不利，脉右伏，左弦细，乃予仲圣小青龙汤原方：

桂枝2克　白芍15克　半夏15克　细辛1.5克　炙麻黄1克　炙甘草2克　干姜1.5克　五味子1.5克

一剂而喘平，再剂咳爽而咯痰便利矣。（录自伤寒论译释《国医杂志·朱阜山医案》）

例三：徐，26岁，酒客，脉弦细而沉，喘满短气，胁连腰痛，有汗，舌白滑而厚，恶风寒，倚息不得卧，此系内饮招外风为病，小青龙去麻辛证也。

桂枝18克　干姜9克　杏仁泥15克　炒白芍12克　生姜五片　半夏18克　炙甘草3克　制五味4.5克　旋复花9克（包煎）（录自伤寒论译释《吴鞠通医案》）

按：综观三案无一不是以外感风寒，内挟水气为主要的致病因素。如第一方因暑天多水浴。第二案因戽水捕鱼而感寒。第三案之内水招外风。由此对原文中“心下有水气”可以有更加深刻的体会。其证状则以咳嗽为主，喘与发热，或有或无，不过使用本方，还须掌握以下两点：

一、本方之适应证，多兼表寒，脉多弦紧兼浮。

二、表邪与水饮均偏于寒，一般的无口渴，舌苔多白滑。

延按：小青龙汤的典型证状，见《伤寒论·太阳篇中》40条。《伤寒论类方汇参》云：于桂枝汤去大枣之甘泥，加麻黄以开玄府，半夏除呕，细辛逐水，干姜、五味以除咳，既用麻黄发表，故不须生姜之横散，水与邪结则用细辛。”解释方药极为明畅。至三例虽同用小青龙汤，但在剂量和加减上各有不同。姜案系用全方无加减。朱案虽用全方，但麻、辛量极轻，因患者系六岁小孩，虑其发散太过之故。吴案用本方去麻、辛，加旋复花，去麻辛，以此证有汗之故；加旋复花，以有胁连腰痛之故。《温病条辨·下焦篇》41条注“旋复花善通肝络而逐胁下之饮”，加旋复花，当系此意。我们读此三案，必须仔细分析，方能获益。

小青龙汤加减证案（一例）

风寒喘嗽误补肺胀

鲍宗海，感风寒，喘嗽多日，某老医谓其证属内亏，药与地、归、参、术，是夜喘嗽益甚，次日复往加减，医谓前药尚轻，更增黄芪、五味，服后胸高气筑，莫能卧下，呻呼不休，闭闷欲绝。予曰：前药加酸敛，邪锢益坚，立方用麻、桂、辛、夏、草、生姜、杏仁、葶苈子，并语之曰：此乃风寒客肺，气阻痰凝，因而喘嗽，医不开解，反投敛补，以致闭者愈闭，壅者愈壅，酿成肺胀危证。《金匮·痰饮咳嗽病》篇云：“咳逆倚息不得卧，小青龙汤主之。”予于方中除五味、白芍之酸收，加杏仁、葶苈之苦泻者，益本《素问·脏气法时论》“肺苦气上逆，急食苦以泻之。”药煎服

后，少顷嗽出稠痰两盂，胸膈顿宽，再服又吐痰涎盏许，喘定能卧。次剂麻桂等味分两减轻，参入桔梗、橘红、茯苓、苏子更为调和肺胃而痊。

安波按：风寒咳嗽，亦一大症也，不可渺视为轻浅者。徐氏灵胎，苦志卅年，始能治咳，先生于小青龙去味、芍、加葶、杏，真善法古人而不泥古人者也。（录自程杏轩医案续录）

延按：古人有伤风误补便成痨之说。此案如认证不清，救治不得法，其后果是不堪设想的。案中引述《内经》，《金匮》的理论来说明病情及加药意义，足见学有渊源。

小青龙汤加味证案（一例）

表寒挟内饮

李某，男，45岁。

咳嗽喘息不得卧，痰白质粘韧难咯。头眩痛，时恶寒，午后微发热，体倦肢楚，历时半月。前医与麻杏石甘汤加味两剂未效。舌苔微黄，脉象弦滑。此系风寒客肺，痰阻气机。治宜散寒肃肺，祛痰定喘。当与小青龙汤；但痰粘韧，舌苔黄，恐病久内有郁热，拟加石膏一味。服一剂。

复诊：喘逆少减，痰转稀白，量多易咯。仍头眩痛，时时恶寒，午后发热已除，舌有灰色薄苔，脉细而缓……郁热已清而恶寒未罢，痰稀，舌灰，脉细，乃系阳气未复，当于前方中去石膏、加附子，服一剂，诸证告愈。（录自伤寒论汇要分析·俞长荣医案）

延按：本证初起属水寒射肺引起咳喘，用小青龙汤极为对证。但从痰粘，苔微黄，脉弦滑等，考虑其兼有郁热而加石膏，追服药后，痰转稀白，量多易咯，舌灰，脉细，显系郁热已清，但阳气未复，故去石膏、加附子以收功，只此一加一减，足见其审证精详，处方灵活，真善于运用经方之佳案也。

栀子豉汤证案（一例）

伤寒虚烦懊憹

江应宿治都事靳相庄，患伤寒十余日，身热无汗，怫郁不得卧，非躁非烦，非寒非痛，时发一声，如叹息之状，医者不知何证，迎余诊视曰：懊憹怫郁证也。投以栀子豉汤一剂，十减二三，再以大柴胡汤，下燥屎，怫郁除而安卧，调理数日而起。

按：此案并未经发汗吐下。但根据其怫郁懊憹，用栀子豉汤即能取效，因为不论汗吐下前，或汗吐下后，只要是因热邪烦扰所致之虚烦懊憹，皆可用之。（录自释《伤寒论译名医类案》）

延按：本证先清宣，后和下，不离调畅肝胃之治法。

栀子生姜豉汤证案（一例）

湿热郁滞懊憹欲呕

郑某，胃脘疼痛。医治痛不减，反增大便秘结，胸中满闷不舒，懊憹欲呕，辗转难卧，食少神疲，历七八日，按脉沉弦而滑，验舌黄腻而浊，视前服方，多桂、附、香、砂之

属。此本系宿食为患，初只须消导之品，或可获愈，今迁延多日，酿成“夹食致虚”，补下均不相宜。乃针对“心中懊侬”，“欲呕”二症，投以栀子生姜豉汤。生栀子　生姜各9克　香豉15克　分温作两服。嘱若一服吐，便止后服。服后，并无呕吐，且觉胸舒痛减，遂尽剂。诸证均瘥，夜间安然入睡，至晨大便已下，并能进食少许。（录自伤寒论汇要分析·俞长荣医案）

延按：本案经实践说明，用生栀子并不致吐，其所以不吐之故，当系湿热郁滞胸阳不宣，生栀子发挥其苦降之功，香豉发挥其宣通之效，况又佐以生姜止呕之品，故能见效。

栀子生姜豉汤加味证案（一例）

纳谷哽噎

叶天士治张五，切脉小弦，纳谷脘中哽噎，自述因平素悒郁强饮，则知木火犯土，胃气不得下行，议苦辛泄降法。

处方：栀子　香淡豆豉　生姜汁炒黄连　郁金　竹茹　半夏　丹皮

按：脉弦脘阻，是肝强侮土之证，又知其平素饮酒，则偏热可知，故以栀子、黄连，苦泄肝木，生姜、半夏，辛散结气，豆豉、竹茹，和胃，郁金、丹皮，和血舒肝，肝平胃和之后，则脘中之哽噎自除。（录自伤寒论详释《伤寒类方汇参》）

延按：本证通过问诊，切诊，知其肝郁不舒，胃失和降，缘胸脘部位，为阳明之表，以下行为顺，木郁之病，以调达为贵，此方舒肝和胃，两擅其长，借用以治哽噎之病，

故能收到一定效果。

枳实栀豉汤加大黄证案（一例）

感后食复

曹近轩翁，夏月患感证，自用白虎汤治愈，后因饮食不节，病复发热腹胀，服消导药不效，再服白虎汤亦不效。热盛口渴，舌黄便闭。予曰：此食复也。投以枳实栀豉汤加大黄，一剂知，二剂已。（录自程杏轩医案初集）

延按：枳实栀豉汤见《伤寒论。辨阴阳易差后劳复》篇，为治大病差后劳复之方。本案因感证后饮食不节而致病，故断为食复，用此方加大黄取效，亦遵方后加法。其用消导药与白虎汤俱不效者，以消导之品耗气伤津，清热之力不足，白虎虽能清热又无消积之功也。

大陷胸汤证案（一例）

上湿下燥

沈家湾陈姓孩，年十四，一日忽得病，邀余出诊，脉洪大，大热，口渴，自汗，右足不得伸屈，病属阳明，然虽口渴，终日不欲饮水，胸部如窒，按之似痛，不胀不硬，又类悬饮内痛，大便五日不通，上湿下燥，于此可见，且太阳之湿内入胸膈，与阳明内热同病，不攻其湿痰，燥热焉除，于是遂书大陷胸汤与之。

制甘遂4.5克、大黄9克　芒硝6克

服后大便畅通，燥屎同痰涎先后供下，乃复用一清热之方，以肃余邪。

按：此案是未经误下，热邪传里。与痰水相结，而成为结胸证。辨证眼目有二：一为口虽渴，终日不欲饮水，口渴是阳明特征之一……今反不渴，乃因胸中素有水饮的缘故。一为胸部如塞，按之似痛，不胀不硬，是邪初传入，结尚未甚的表现，加之大便五日未通，可知是不独水热结于胸，且肠中亦已燥结。此时若但清其上，则邪无去路，徒攻其下，则胸中邪不能解，大陷胸汤方用甘遂以逐水，大黄、芒硝润燥通便，一方而两扼其要，所以能应手取效。（录自伤寒论译释《经方实验录·曹颖甫医案》）

延按：此案与《伤寒论》大陷胸汤证条“伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者”似不相符，但彼系热结于里较甚之重证，本案为邪初传入，结尚未甚之轻证，证虽有轻重不同，其为水邪结于心胸，热邪实于肠胃的病理机转则是一致的，故仍可运用此方以收效。

又按：本方煮服法后云：“先煮大黄，去滓，内芒硝，煮一两沸，纳甘遂末，温服一升，得快利，止后服。”必须注意，否则易导致不良后果。

小陷胸汤加减证案（一例）

痰热互结胸膈

缪仲醇治姚平子伤寒，头痛身热，舌上黄胎，胸膈饱闷，

三四日热不解，奄奄气似不续者，亟以大黄30克，瓜蒌二枚（连子切片）、黄连、枳实下之，主人惊疑，不得已，减大黄之半，二剂便通热立解，遂愈。

按：此案之奄奄气似不续，是由于胸膈饱闷，气机窒塞所致，若误认为虚，投以补剂，必将导致不良后果。缪氏用小陷胸汤加减，且重用大黄剂量，想见其痰热互结之甚。（录自伤寒论译释《续名医类案》）

延按：此证用小陷胸汤去半夏，加大黄、枳实，想因痰热互结过甚，以致上下气机不通，去半夏避其辛燥。至开痰热互结，方中全瓜蒌一物已足胜任。因便秘不通，故加枳、黄速其通降之力。其认证精确并不为气息奄奄假象所迷惑而敢于大胆用通下。其辨证要点，在舌黄身热，胸闷，便秘上。

大黄黄连泻心汤证案（一例）

酒客吐血

史，50岁。酒客大吐狂血成盆，六脉洪数，面赤，三阳实火为病，与大黄18克　黄连、黄芩各15克，泻心汤一帖而止，二帖脉平，后七日又发，脉如故，又二帖。

按：根据本条，可知大黄黄连泻心汤，不但是痞的主方，而且也是治实热血证有效方剂，如能运用得当，其疗效是相当可靠的。（录自伤寒论译释《吴鞠通医案》）

延按：本案用此汤治疗血证，当系据据《金匮·惊悸吐衄下血胸满瘀血》篇，“心气不足，吐血、衄血，泻心汤主

之。”而立法处方的。所谓不足，乃因壮火食气之故，非真不足也，故用三黄直折其热，则火降而血自止。

附子泻心汤证案（二例）

1、上热下寒

宁乡学生某，得外感数月，屡变不愈，延诊时，自云：胸满，上身热而汗出，腰以下恶风。时夏历六月，以被围绕，取视前所服方，皆时俗清利，搔不着痒之品，舌苔淡黄，脉弦，与附子泻心汤注。阅二日复诊，云药完二剂，疾如失矣。为疏善后方而归。

注：《伤寒论·辨太阳脉证并治下》160条

按：胸满，上身热而汗出，腰以下恶风，以被围绕，正是邪热有余，正阳不足之征，附子泻心汤自为的对之方，所以用之有效。其给药法，应照原法，三黄用渍，附子用煎的方法，方为确当。（录自伤寒论译释《遯园医案》）

延按：本条原文叙述较简，此案补出舌苔，脉象，可供临床参考。

2、上热下寒吐血

郑某，男，36岁。因操劳过度，忽然口吐鲜血，吐血后畏寒，胸中痞闷，足胫厥冷，面色反赤，脉浮芤，血色鲜红，知非宿瘀；面赤脉浮，显系心火上炎。因热炽于上，形成上热自热，下寒自寒现象；胸中痞闷，正是因寒热互结所

致。现吐血未止，急则治标，拟“釜底抽薪”法，使心火下降，不但吐血可止，且胸痞亦能因火降寒热调和而自解。但病者尚有畏寒感觉，虑及阳虚，遂决定先用附子泻心汤，以三黄泻心火，使热下行，附子固护阳气。

处方： 大黄9克　黄连　黄芩各6克　附子6克　水二碗，煎一碗冷服。

次日复诊，血止，胸痞解除，但全身发热，心悸，脉转弦细，此乃失血后之虚热，拟清余热，交心肾法，与黄连阿胶汤。

处方： 黄连6克　黄芩4.5克　阿胶9克（另烊）白芍9克　鸡子黄两个（另冲）

上药连服二剂，热退，脉转沉细，心悸未除，精神疲倦，嗣以归脾汤去木香、龙眼肉，加胶饴二两，再服两剂而愈。（录自伤寒论汇要分析，俞长荣医案）

延按： 《金匮·惊悸吐衄下血胸满瘀血》篇载：“心气不足，吐血衄血，泻心汤主之”。本案据此立方，因有畏寒感，故加附子而为附子泻心汤，考《伤寒论·太阳篇下》160条附子泻心汤后煮服法系轻渍三黄，浓煮附子，此则合煎，妙在冷服，附子仅用6克，可知注重治上热而兼顾其下寒也。迨血止痞解寒去后，又出现失血后虚热，用黄连阿胶汤，仍不失泻心之义。（柯韵伯谓此汤为少阴之泻心汤也）。

半夏泻心汤证案（一例）

疟后痞呕

林某，男，30岁。患疟疾三天，经内服奎宁片后，疟疾

虽止，但觉胸中痞闷，食后欲呕，但又不得呕，尤其见到油腻食物即生恶心感。甲医认为疟后余邪未解，与小柴胡汤两剂，未见减轻；乙医认为疟后脾虚，进以六君子汤两剂，痞闷更甚。

患者脉弦，舌苔白，自述除胸痞，恶心欲呕外，并无其它痛苦。此证断为疟后余邪未解尚是，但无往来寒热于外，非小柴胡汤所主。至于认为脾虚而用六君子汤，则似嫌过早。

本病虽无往来寒热于外，但有寒热互结于内，所以胸中痞闷，治拟予半夏泻心汤，药取寒热消补并施，仍不离少阳和解之意。

处方：半夏9克　黄芩6克　潞党参9克　干姜4.5克　甘草3克　大枣三枚

服一剂后，恶心全除，胸痞大减，食欲稍振。次日照原方再服一剂而愈。（录自伤寒论汇要分析，俞长荣医案）

延按：半夏泻心汤证，一见于《伤寒论·太阳篇下》154条，一见于《金匮·呕吐哕下利》篇，主要证状，俱有痞与呕，本案虽属疟后，但病机相同，故用此方有效。

半夏泻心汤加味证案（一）

伤食吐泻

黄儿，5岁。伤食吐泻，口渴尿少。医者不问病原，贸然进以温补药，企图止之，病反剧。后医又以水湿分利失常，治以五苓散，渴未减而吐利如故。余视其指纹淡红隐隐，心

烦欲饮，水入则吐，食亦少进，舌苔黄白而腻，腹鸣下利，时呕，大便稀，淡黄有腥气，嗜睡不少动，病月余矣。综合判断，乃系肠热胃寒，食积湿困之象。既不可温，又不可汗，治宜寒温并用，处以半夏泻心汤。半夏降逆止呕，参、姜益气温中，芩、连清理肠热，枣、草甘温和胃，枢转其间，增茯苓健脾利水，花粉生津止渴，以宏效果。服后吐泻均减，再剂病痊。惟病久虚极，进以参苓白术散平调脾胃，十剂能行，又半月而健。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本案虽由伤食引起，但既已吐泻，伤中耗津，又病经月余。其心烦欲饮，水入则吐，颇似五苓散证，用五苓不效者，以此方只能分利水湿，而无辛开苦降之功也，根据指纹和证状综合判断，以为肠热胃寒，食积湿困之征，故借用半夏泻心汤增入利水生津药品，其处方用药大意，自注已详，不赘述。

黄连汤证案（二例）

1、 呕 吐

陈襄人，男，25岁。久泻愈后，又复呕吐，医进参、术，砂、半，复进竹茹、麦冬、芦根诸药杂投无效。其证身微热，呕吐清水，水入则不纳，时有冲气上逆，胸略痞闷，口不知味，舌光红燥，苔腻，不渴，脉阴沉迟而阳浮数，乃上热中虚之证。应用黄连汤。方中姜、桂、参、草，温脾胃而降冲逆，黄连清胸热，伴半夏以止呕吐，为一寒一热错综之良方。服药呕吐渐止，再剂，证全除，能进稀弱，后用五味

异功散加生姜温胃益气而安。（录自赵守真治验回忆录）

延按：徐灵胎云："诸泻心之法，皆治心胃之间寒热不调，全属里证。此方即半夏泻心汤以黄芩易桂枝，去泻心之名而曰黄连汤，乃表邪尚有一分未尽，胃中邪气尚当外达，故加桂枝一味以和表里。"本证身微热与冲气上逆，均为桂枝所主，其余寒热并用，补散兼行，为和法之最佳者。

2、上热下寒

黄某，宁乡人，先患外感，医药杂投，后更腹痛而呕，脉象弦数，舌色红而苔黄，口苦。余曰：此甚易事……与黄连汤，果瘳。

按：此证系由外感，治不得法，而表邪入里，造成上热下寒，阴阳升降失常之证，与黄连汤乃药中病机，故能一剂即愈。（录自伤寒论译释《遯园医案》）

延按，本案证状与《伤寒论·太阳篇下》178条符合，并补叙舌苔，味觉，脉象，更较具体，可供临床参考。

生姜泻心汤证案（二例）

1、痞满便溏腹鸣

潘某，初患头痛，往来寒热，余以小柴胡汤愈之，已逾旬矣。后复得疾，诸医杂治益剧。延诊时云：胸中痞满，欲呕不呕，大便溏泄，胀中水奔作响，脉之紧而数，疏生姜泻心汤注。一剂知，二剂愈。

注：《伤寒论·太阳篇下》162条

按：此案之证状与本条颇为吻合，其主要见证，皆已具备，故能一剂知，二剂已。（录自伤寒论译积《邃园医案》，

延按：本方即半夏泻心汤全方，再加一味生姜，不曰半夏泻心加生姜，而名生姜泻心汤者，意在以生姜为主药也。方中干姜生姜并用，但功效各有不同，干姜长于守，意在温里而祛寒。本证由于胃虚不和，水蓄不行，为制散水攻痞之方，以生姜长于散，意在和胃而祛水也。

2、胃痛肠鸣

杨某，女，17岁。始见胃脘疼痛，继则呕腐吐酸，如此发作无常，持续四年有奇。今年入春以来，竟至胃不受纳，或食入不久即吐，吐出均系未消化食物。胃脘痛时，腹中有块状物浮起，可以触知。小腹拘急而大便难通。面色苍白，精神困倦，腰痛，四肢痿楚。月经于十五岁初潮，旋即停经迄今，白带多，舌苔薄白而滑，右脉沉弦，左脉沉细。诊断为肝胃不和，治拟和胃疏肝降逆。

处方：旋复花　代赭石各9克　太子参12克　黄连6克　半夏　生姜各9克　吴萸3克　甘草3克　水煎服一剂。

次诊：胃痛呕吐暂得缓解，腹中肿块消失，大便已通。但心中觉痞，舌脉同前。

处方：旋复花9克　吴萸4.5克　野山参3克　半夏9克　黄连　黄芩　生姜各6克　干姜4.5克　甘草3克　水煎服两剂。

经两次治疗后，自觉症状基本消失，饮食正常。近日胃痛吞酸，嗳腐吞酸，朝食暮吐等证复发，兼见腹胀肠鸣，大便溏泄，一日数行。脉沉细软，舌苔白滑，再循前法施治。

处方：半夏　党参　生姜各9克　黄连　黄芩　炙草各6克　干姜4.5克　大枣三梅　连服五剂，诸证消失。

案后俞氏自注云：本例初就诊时，发病数年，体虚可知；而腹中有块状物浮起，小便拘急，大便难通，又系属实。食入即吐，责之胃热，而舌白滑，脉沉细，又系属寒。总缘脾胃虚弱，寒热互隔，以致中焦通降失职，故药取寒热消补并施。后一阶段来诊时，症状基本如前，所不同者为腹无浮块，而腹胀肠鸣，大便溏泄。证仍不离寒热互隔，兼见水气下趋大肠。故采用生姜泻心汤，仍取寒热消补并施之意，兼除肠间水气。（录自伤寒论汇要分析·俞长荣医案）

延按：本证初诊为肝胃不和，故方拟旋复代赭合左金。次诊仍本前法，因之肝胃不和现象得以缓解。最后出现肠鸣溏泄，嗳腐，苔白滑等水气停滞之证，故用生姜泻心汤获效。

减味旋复代赭石汤证案（一例）

（膈气）

喻嘉言治一人膈气，粒食不入，始吐清水，次吐绿水，次吐黑水，次吐臭水，呼吸将绝。一昼夜，先服理中汤六剂，不令其绝，来早转方，一剂而安……吾于此病，分别用之者有二道，一者以黑水为胃底之水，此水且出，则胃中之

津久已不存，不敢用半夏以燥其胃也。一者以将绝之气，止存一丝，以代赭石坠之，恐其立新，必先以理中分理阴阳，使气易于降下，然后代赭石以建奇奇绩，乃用旋复花一味煎汤调代赭末二匙与之，才入口即觉其气转入丹田矣。雨倦之极，服补药20剂，将息二月而愈。

按：此案告诉我们两个问题，一为治病当分虚实缓急，如此证直接用本方，必不能获效；一为运用古方，必须灵活，如此案只服本方两味，亦能获效，即是明证。（录自伤寒论译释《寓意草》）

延按：此证喻氏分析病情及用方先后步骤，非常明晰，化裁古方，使适应病情，亦其见图酌。

五苓散证案（三例）

（呕吐）

林幼春，青年木工。近日身发热，渴欲饮水，但水入则吐，饮食亦少进。常感胃脘满胀，舌苔淡黄不燥，小便黄短。先进不换金正气散无效，又转香砂二陈汤，胃胀虽得减，而呕吐终未止。历时半月，证情转剧。切脉浮数，身仍有热，胃胀时呕，吐水则胀减，水食皆难入，小便不利。本证为水气内阻，津液不生，而非由于胃中之燥热所致，故宜化气行水之五苓散。遂给以此方，呕吐遂止。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本证具备了五苓散典型脉证，所以服之有效。其初病时治疗之方，不过顺气化痰和胃之品，而未从水气着

眼，故无效或虽小效而不彻底也。

2、反胃

唐慎元，年30余。病反胃，心下雷鸣不舒，食辄胀满，吐出而后快，吐后则思水，饮水却不吐。诸医杂治，药多罔效。切脉浮而迟，舌白润无苔，胃胀有鸣声，食后仍吐，小便清长，大便自可。其病在水，水去则胃运恢复，食入可消，胃反何来。现胃虽有停水，脾尚未虚，不宜理中之温补，而以燥土利水之五苓散为切。方中应用肉桂具温阳化气之效，苓、术培土燥湿，猪、泽清热渗利。遵古法研末为散，白汤送服，效始易显，服药后，果愈。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本案分析用五苓不用理中之故，以及五苓散用肉桂，不用桂枝，并研散服，不用汤剂，均应注意。

3、胱膀蓄水

程，男，证见高热口渴，谵语不眠，小便短赤，脉浮洪大。连给大剂人参白虎汤三剂，不但证状无减，口渴反而增剧。急问病者，喜热饮否？答喜热饮，虽至手不可近，亦一饮而尽。再细察其舌，质红无苔而滑，因思脉浮洪大，发热，虽似白虎汤证，但口渴喜热饮实非白虎汤所宜。此乃无根之火上浮，故口渴喜热，舌红而滑；虚火乱及神明，故谵语，火不归位，膀胱气化失职，故小便短赤。当按膀胱蓄水证治。遂用五苓散改汤剂，桂枝用肉桂以引火归元。（每剂

用桂2.5研末，分两次冲服）。仅两剂，热退口和，小便清利。后调理半个月复元。（录自伤寒论汇要分析·俞长荣医案）

延按：五苓散证，《伤寒论·太阳篇中》71、74、两条，谈得较具体，但彼用桂枝，是因表未解，此用肉桂，系引火归元。

十枣汤证案（三例）

1、痰饮胸痛

罗妇冬芙，原有胸痛宿疾，一年数发，发则呼号不绝，惨不忍闻。今秋发尤剧，几不欲生。服瓜蒌薤白枳实厚朴半夏汤及木防已汤多剂皆不效。按脉弦滑，胸胃走痛，手不可近，吐后则稍减，已而复作，口不渴，小便少。但痛止则能食，肠胃殊无病。证似大陷胸而实非，乃系痰饮之属。明是水饮结胸作痛，拟十枣汤主治。

处方：甘遂　大戟　芫花各1.5克研末，用大枣十枚煎汤一次冲服。

无何，肠鸣下迫，大泻数次，尽属痰水，痛遂止，续以六君子汤调理。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本案属痰饮为病，弦滑为痰饮之脉，走痛拒按，为水饮结聚之征，所以用开胸理气降逆方剂无效，而用十枣汤见功也。

2、悬饮胸痛

刘君一，中医。患胸膈胀满，气促喘急，面微浮肿，自服宽胸调气药不效。西医诊断为胸腔积液，胸腔积水甚多，曾抽水数百毫升，暂获轻松，但不久又如原状。按脉弦滑，胸脘胀痛，喘急不安，属中医书载之悬饮内痛，系中阳不振，水不运化，结聚胸膈，因而胀痛，及呼吸转侧，均觉困难。治当峻攻其水，十枣汤，大陷胸汤，皆为本证方剂，但大陷胸汤适合胸水及肠胃积热而大便不利者。本病仅为水饮结胸肠无积热，则以十枣汤为宜（注）。

处方：甘遂2.5克　大戟　芫花各3克研末，另大枣十枚煎汤送下，分二次冲服。

服竟，峻下四五次，连服两日，胸不胀满，气亦不喘，此由胸腔积水已经逐荡而从大便去也。后以《外台》茯苓饮（茯苓、人参、白术、枳实、橘皮、生姜）健脾利水，续服半月愈。（录自赵守真治验回忆录）

注：《伤寒论·太阳篇下》157条

延按：本案经西医诊断为胸腔积液，属中医悬饮范畴，故用十枣汤。其阐述大陷胸与十枣汤之作用，足见辨证之重要和中西结合之可法，善后用外台茯苓饮，亦见其考虑周到。

3、饮结胁下

张任夫，水气凌心则悸，积于胁下则胁下痛，冒于上

膈，则胸中胀，脉来双弦，证[illegible]饮家，兼之干呕短气，其为十枣汤证无疑。

处方：炙芫花　制甘遂　大戟各1.5克研细末，分作两服，先使黑枣十枚煎烂，去渣，入药末，略煎和服。

按：原书中此案后说明病者服上药后，即感到喉中辛辣，甚于胡椒，并有口干心烦发热声哑等现象，服后二小时，即泻下臭水，病者即感到两胁舒适，能够自由转侧。从这一病例中，说明十枣汤的功用，是非常峻猛的，但只要证情合拍，就能很快的收到效果。（录自伤寒论译释《经方实验录，曹颖甫医案》）

延按：本方是逐水的峻猛剂，观服后的药效反映可知。此点须预告病家，免致慌乱，杂药乱投，反致憤事。但用此方时，应十分审慎，必入实证实，中病即止，或仿陈无择法改汤为丸较妥。

十枣汤变汤为丸证案（一例）

饮 积

王金坛曰：予内弟于中甫，饮茶过度，且多憤懑，腹中常漉漉有声，秋来发寒热似疟，以十枣汤料黑豆煮，晒干研末，枣肉和丸芥子大，而以枣汤下之，初服1.5克不动，又服1.5克，无何腹痛甚，以大枣汤饮，大便五六行，皆溏粪无水，时盖晡时也，夜半，乃大下数斗积水而疾平，当其下时，瞑眩特甚，手足厥冷，绝而复苏，举家号泣，咸咎药峻，嗟乎，药

可轻用哉。（录自古今医案按）

延按：此证仿抵当丸例，峻剂而行之以缓，制法既用枣肉和丸，又下以枣汤，无非以顾护胃着眼，但水积既去，应用理脾涤饮之药以善其后较妥。

白虎汤证案（二例）

1、　三阳合病

吴光录患伤寒，头痛腹胀，身重不能转侧，口内不和，语言谵妄……此三阳合病也。……乃与白虎汤连进两服，诸证渐减，更加麦冬、花粉，两剂而安。

按：本案所述证候，大部与《伤寒论·阳明病篇》224条吻合，所以白虎汤疗效很好。两服后更加花粉、麦冬滋液生津，亦很妥切。（录自伤寒论译释《续名医类案·李士材案》）

延按：本案应与太阳风湿和阳明府实证作鉴别，因身重腹满似风湿，但风湿偏表，当无里热证；语言谵妄似胃实，但又无腹满拒按潮热等证。根据出现的一系列证状，虽云三阳合病而邪聚于阳明经太少为多。所以柯韵伯说："里热而非里实，故当用白虎而不当用承气"可谓扼要之言。

2、　阳明经热证

伍某，30余岁。病太阳中风，医误以麻黄汤发汗太过，致大伤津液，出现壮热，面赤，大汗淋漓，烦躁，气喘，脉

象洪大。用白虎汤生石膏重用，服后热退病愈。（录自1963年广东医学祖国医学版1期40页庇留医案）

延按：本证过汗伤津，如何不用白虎加参？因患者在壮年，体质强健，病起于暴，既无大烦渴不解证，脉亦不见虚象，故一用白虎则阳明经热清，而汗自止，热自退，津自回也

白虎汤加味证案（二例）

1、 湿温

许学士云：故人王彦龙，作昆陵仓官，季夏时，病胸项多汗，两足逆冷，谵语，医者不晓，杂进药，已经旬日。予诊之，其脉关前濡关后数。予曰：当作湿温治之，盖先受暑后受湿也。难经（五十八难）曰："湿温之脉，阳濡而弱，阴小而急"。濡弱见于阳部，湿气搏暑也，小急见于阴部，暑气蒸湿也。暑湿相搏，是名湿温。先以白虎加人参汤，次白虎加苍术汤，头痛渐退，足渐温，汗渐止，三日愈。（录自古今医案按）

延按：案中有两足逆冷现象，由热壅于上而不下达之故，王孟英氏在其治案中曾论及之，不可误认为上热下寒。此证先受暑，经医治不如法，迁延旬日，热盛耗津，故加人参以清热救津，后受湿，故加苍术以清热燥湿，其引难经文以释脉象，亦甚恰当。

2、热病头痛壮热渴呕

缪仲淳治铨部章衡阳，患热病，头痛壮热，渴甚且呕，鼻干燥不得眠，其脉洪大而实，一医曰：阳明症也，当用葛根汤。仲淳曰：阳明之药，表剂有二，一为葛根汤，一为白虎汤，不呕吐而解表，用葛根汤，今吐甚，是阳明之气逆升也，葛根升散，用之非宜，乃与大剂白虎汤加麦冬、竹叶，医骇药太重，仲淳曰：虏荆非六十万人不可，李信二十万则奔还矣。别后进药，天明遂瘥。（录自古今医案按）

按：此病既壮热渴呕，内热如此之甚，用葛根汤当然不宜。本案用大剂白虎，加麦冬、竹叶，有竹叶石膏汤方意，吐甚，为阳明之气逆升，故不用辛燥之半夏以降逆。愚见可于本方再加花粉、黄连、竹茹之类药品，则效力更大。

白虎加人参汤证案（五例）

1、伤寒吐下后热盛伤津

一人病伤寒，初呕吐，俄为医下之，已八九日，而内外发热。许诊之，曰：当用白虎加人参汤。或曰：既吐复下，宜重虚矣，白虎可用乎。许曰：仲景云："若吐下后，七八日不解，热结在里，表里俱热者，白虎加人参汤"。盖始吐者，热在胃脘，今脉洪滑，口大渴，欲饮水，舌干燥而烦，非人参白虎不可也。（录自古今医案按·许学士案）

延按：许案引仲景语，见《伤寒论·太阳病下》178条。脉证俱与阳明经热盛相符，因吐下伤津，故用此方极合。

2、伏热发斑

赵氏子病伤寒十余日，身热而人静，六脉尽伏，俚医以为死人也，弗与药。吕元膺诊之，三部举按皆无，其舌胎滑，而两颧赤如火，语言不乱。因告之曰：此子必大发赤斑，周身如锦纹。夫脉血之波澜也，今血为热邪所搏，淖而为斑，外见于皮肤，呼吸之气，无形可依，犹沟渎之水，虽有风，不能成波澜，斑消则脉出矣。及揭其衾，而赤斑烂然，即用白虎加人参汤化其斑，脉乃复下，继投承气下之愈。发斑无脉，长沙所未论，元膺盖以意消息耳。（录自古今医案按）

延按：本案重在治阳明，盖斑出于胃，胃主肌肉，治法先清阳明经热，后下阳明府实，先表后里，井然不乱。后世化斑汤，系白虎汤加元参、犀角，并录存参。

3、劳倦中暑

江应宿治其岳母，年六十余，六月中旬，身热如火，口渴饮冷，头痛如破，脉虚豁，二三至一止，投人参白虎汤三帖，渴止热退，惟头痛，用白萝卜汁吹人鼻中，良愈。（录自古今医案按）

延按：此证用白虎汤自是正法，惟脉不洪大而虚豁，故加人参以扶元气。白萝卜汁吹鼻中的外治法亦妙。

4、癞　　疟

张路玉治顾大来，年逾八旬，初秋患痟疟，昏热谵语，喘乏遗尿，或者以为伤寒谵语，或者以为中风遗尿，危疑莫定，路玉曰：无虑，此三阳合病，谵语遗尿，口不仁而面垢，仲景暑证中，原有是例，遂以白虎加人参，三啜而安。

震按：内经论痟疟，纯是实热证。故推其未病，则曰中气实而不外泄。溯其受病，则曰用力出汗，风寒舍于皮肤分肉。究其病发，则曰阳气盛而不衰，经文虽不言脉，谅脉之洪实有力可知也，此条系痟疟，故谵语遗尿不知，然八旬之外有此证，死者甚多，勿轻以此案作榜样也。（录自古今医案按）

延按：伤寒论中三阳合病，热邪炽盛，独治阳明，用白虎汤确系对证，此案加参者，恐顾虑其八旬高龄，故于清解剂中加益气生津之人参以筹万全之策也。

5、产后温病

林某妻，产后三日，发热不退，口渴，烦躁不安。前医认为"败血攻心"症，以生化汤加减治疗，反增气急，谵语，自汗出。病后三日（即产后三日）请诊：

患者脉洪大而数，舌质红绛而燥，与人参白虎汤。

处方：生石膏37克　知母9克　潞党参31克　炙甘草6克

嘱以粳米125克，用水三大碗，煮至微熟为度，取米汤

三杯入上药，煎成一杯；剩余米汤留作次煎用（次煎两杯煎一杯）日服两次。

时值隆冬季节，病家见方中有石膏，颇为疑惧。盖以石膏大寒，且俗例“产后宜温不宜凉”所以犹豫不敢服用。后经解释，古人治产后病，亦有用攻下或寒凉者。现病者高热，烦躁，汗出，脉洪数，舌质红绛燥，是因热甚劫津，故前医用生化汤加减，病状反而增剧，便是明证。此证此时，急须清里热，救津液，用人参白虎汤乃依证施药。方中虽用石膏31克余，尚未到极量，且先煮粳米作汤，可以扶脾胃养阴液；重用潞党参，能保护元气不致过伤，纵使无效，决不至贻害。服一剂症状大减，次日按原方再服一剂而愈。

这说明方药应用，当根据病情施治，不能受季节所拘。（录自伤寒论汇要分析，俞长荣医案）

延按：徐灵胎说：“产后血脱，孤阳独旺，虽石膏、知母对证亦不禁用，观此案益信。但产后有类白虎一证，亦有大热汗渴现象，惟脉洪大按之无力，须用当归补血汤治疗，当与此对勘，细心分析，庶不致误。

人参白虎汤加减证案（一例）

中　　暑

汪石山治一人，年卅余，形瘦弱，忽病上吐下泻，水浆不入口者七日，自分死矣。汪诊脉八至，曰：当夏而得是脉，暑邪深入也，用人参白虎汤进一盂，稍安，后减去知、膏，加

人参至12—15克，以黄柏、陈皮、麦冬等、随所兼病而佐使，一月平复。（录自古今医案按）

延按：本证虽吐泻，水浆不入口，但以其在壮年，且病起于暴，脉又八至，故断为中暑，白虎是正治之方，以其吐泻伤正故加参，其后去知、膏，加重人参剂量，恐知、膏之寒，伤残胃气，最后加黄柏、陈皮、麦冬等养阴健胃除湿之品，盖师李东垣清暑益气汤之意，以暑多兼湿也。

竹叶石膏汤加减证案（一例）

小儿口渴尿多

刘小毛，男，3岁。先患吐泻，经服药一周后，吐泻全止。旋而烦渴，引饮不休，小便每小时十至十五次不等。舌紫红无苔，指纹显露而深红，喜卧地下，午后有潮热，夜半汗出而解，食欲不振，尿清长，时作干呕，肌肉日形干瘦，睛光尚好，犹可自由行动，此为阴虚内热，治宜滋阴清燥法，处竹叶石膏汤加减。本方虽为病后津气两伤余热未尽之清补一法，但移以治肺胃之热亦可。方中竹叶、麦冬清心肺之热，石膏原治烦渴引饮，与麦冬配用，效力尤巨，又人参改洋参则具强心生津作用，去半夏之辛燥，易花粉之清润，甘草和中，粳米益胃，实各有相辅相承之义。是以用之以清肺热，肺热则宣化，宣化则津生，津液四布，不专下注，则尿少而渴自止，自以清肺热为第一要着。因此，更知本病之适用竹叶石膏汤，乃依上法煎服。另以蚕茧、麦冬、山药水煎

作茶饮。药进三剂，疗效显著，渴尿均减，稍能进食，潮热止，汗不出，只余渴尿两证，势亦已衰。再四剂，口不渴，尿亦趋正常，遂用参苓白术散调理收功。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本证根据所表现一系列证状，析为阴虚内热，处以竹叶石膏汤加减，非常恰当。方中去半夏、加花粉、仿小柴胡加减法，人参改洋参五钱，且不易购，不如重用北沙参、玉竹代之。如呕尚未止，既去半夏则少征呕之力，应以竹叶易竹茹既清热又止呕，如此化裁，当亦不背原意。至善后不用温补而用甘淡平补，更见考虑周到。

调胃承气汤证案（一例）

少腹厥气上冲

马元仪治袁玉行，少腹厥气上冲，即吐，得饮则吐愈甚，诸药不效。马诊之，两脉虚濇右尺独见弦急，此下焦浊气上腾，则胸中阳气不布，故饮入于胃，上涌而不下达，宜通其地道，用调胃承气汤，下宿秽甚多，继渐培中气而愈。

震按：凡病皆有虚实，勿谓气冲证皆系阴虚气虚也。故选此条，别开一例，然必是暴病或便秘，乃从右尺脉印其机耳。（录自古今医案按）

延按：此病究系实中兼虚，故下法不用大小承气而用调胃承气，恐亦见其两脉虚濇之故，观其善后仍培中气，可以见矣。

小承气汤证案（二例）

1、伤寒里实

许学士治一人病伤寒，大便不利，日晡潮热，两手撮空，直视喘急，更数医矣。许曰：此诚恶候，见之者皆死一生，仲景虽有证而无治法，况已经吐下，难于用药，勉强救之，若大便得通而脉弦，则可生，乃与小承气一服，大便利，诸疾渐退，脉且微弦，字月愈。或问曰：下之而脉弦者生，此何谓也？许曰：仲景云："循衣妄撮，怵惕不安，微喘直视，脉弦者生，濇者死，微者但发热谵语者，承气汤主之。予观钱氏（仲阳）直诀《小儿药证直诀》云："手循衣领及捻物者，肝热也，此症在仲景列于阳明部，盖阳明者胃也，肝有热邪，淫于胃经，故以承气汤泻之，且得弦脉，则肝平而胃不受克，所以有生之理也。（录自古今医案按）

延按：许引仲景语，见《伤寒论·阳明病篇》217条，但该条系用大承气汤，本案仅用小承气汤，想因本病经数医误治之后，不敢放胆峻攻，故采用小承气轻下之法耳。

2、下利懊侬腹胀痛

王月怀伤寒至五日，下利不止，懊侬腹胀，诸药不效，有以山药、茯苓与之，虑其泻脱也。士材诊之，六脉沉数，按其脐则痛，此协热自利，中有结粪，小承气倍大黄服之，

果得结粪数枚，利遂止，懊侬遂安。（录自古今医案按，李士材案）

延按：此案通过切诊和触诊，判断其下利为协热自利，懊侬腹胀，为里热壅滞，故用小承气倍大黄以下其结热，本"通因通用"之法，故效。

大承气汤证案（三例）

1、热极似寒

戴原礼治朱仲文，长夏畏寒，身挟重纩，食饮必热如火，方下咽，微温即呕，他医授以胡椒制硫，日令啖鸡三，病愈亟，原礼曰：脉数而大，且不弱，刘守真云：火极似水，此之谓矣，椒发阴经之火，鸡能助痰，只以益其病耳，以大承气汤下之，昼夜行廿余，顿减纩之半，复以黄连导痰汤加竹沥，饮之竟瘳。（录自古今医案按）

延按：此证不惑于外显假寒之现象，而竟用承气下之者，诚如俞东扶之按语，因其多服热药而病益甚，且脉不微弱也。除此之外，想其人平日必嗜厚味且体实而病起于暴，观其日啖三鸡，其胃气之强可见，非虚羸久病可比。治法，先下其热，后涤其痰，亦系针对病情以立法处方，故效。

2、阳明内实呃逆

虞天民治一人伤寒，前医以补药治之而发呃逆，十日后，邀虞诊之，其脉长而实大，此阳明内实，误补所致，与

大承气下之，热退而呃止。（录自古今医案按）

延按：本案脉实而误补，故用下得愈。与《金匮，呕吐哕下利篇》，“哕而腹泻，视其前后，知何部不利，利之则愈。”其理相通。

3、体厥脉厥

李士材治韩茂远，伤寒九日以来，口不能言，目不能视，体不能动，四肢俱冷，皆曰阴证。士材诊之，六脉皆无，以手按腹，两手护之，目皱作楚，按其趺阳，大而有力，乃知腹有燥矣也。与大承气汤，得燥矢六七枚，口能言，体能动矣。故按手不及足者，何以救此垂绝之证耶。

震按：六脉无而诊趺阳，鉴于仲景之自叙，读书诚有用也。（录自古今医案按）

延按：本证属真热假寒，外证现体厥脉厥，内则腹痛拒按，趺阳脉大而有力，均属里实可攻之象，故用大承气汤见效。

大承气汤加味证案（一例）

寒凝瘀滞腹痛

丹溪治一人，六月投渊取鱼，至秋深雨凉，半夜小腹痛甚，大汗，脉沉弦细实，重取如循刀责匕然，与大承气汤加桂二服，微利痛止，仍连日于申酉时腹痛，坚硬不可近，

每与前药，得微利，痛暂止，于前药加桃仁泥，下紫黑血升余，痛亦止，脉虽稍减，而责匕然犹在，又以前药加川附子，下大便五行，有紫黑血如破絮者二升有余，又伤食，于酉时腹痛在脐腹间，脉和，与小建中汤，一服而愈。

案按：小腹痛甚，大汗，脉如循刀责匕，昧者必认为真脏脉矣，否则认其病因是寒，惟用桂附耳，丹溪连以温药下之，殊不可及，最难者痛止复作，不改前方，陡加桃仁，迨瘀下痛止，仍不改前方，又加附子，至愈后伤食腹痛，忽变前方而用建中，总由指下认得真，故攻补毫无疑惑也。（录自古今医案按）

延按：本案属寒凝瘀滞，里气不通，故痛。其痛不在大腹而在小腹者，因积久邪深使然也。药用大承气加桂、附，是仿大黄附子汤温下之法，因兼瘀滞，所以又加桃仁，得下紫黑血而痛止，所谓通则不痛也。迨瘀滞去，即转手而用建中，先攻后补，治法井然。

桃仁承气汤证案（一例）

热盛致衄

滑伯仁治一妇，体肥而气盛，自以无子，尝多服暖宫药，积久火盛，迫血上行为衄，衄必数升余，面赤，脉躁疾，神恍恍如痴，医者犹以上盛下虚，丹剂钲坠之。伯仁曰：经云：上者下之，今血气俱盛，溢而上行，法当下导，奈何实实耶，即与桃仁承气汤三四下，积秽去，继服既济

汤，甘剂而愈。（录自古今医案按）

延按：此证用桃仁承气以导血下行，固当，但此妇多服煖下药，内热如此之盛，则方中桂枝似宜减去，再加丹皮、牛膝、茅根、藕节、茜草等药较妥。

桃仁承气汤加味证案（二例）

1、痢兼瘀滞

吴菱山治一妇，长夏患痢，痛而急迫，其下黄黑色，诸医以薷苓汤，倍用枳壳、黄连，其患愈剧，吴诊之，两尺脉紧而濇，知寒伤荣也。问其病由，乃行经之时，因渴饮冷水一碗，遂得此证，盖血被冷水所凝，瘀血归于大肠，热气所以坠下，遂用桃仁承气汤，加马鞭草、延胡索，一服，次早下黑血升许，痛止脏清，次用调脾活血之剂，遂痊，此乃经凝作痢，不可不察也。

震按：此条先用薷、连，其患愈剧，再合以尺脉之紧濇，明知为寒伤荣矣，乃不用温药佐消瘀，仍以承气加逐瘀药，岂因后重急迫，宜下不宜温耶。（录自古今医案按）

延按：本证通过切诊和问诊，得其病情，因长夏患痢，属湿热郁滞者多，温药当考虑使用，血热被冷遏阻，用桃仁承气恰好，加马鞭草、延胡二味，增强祛瘀钲痛之力，尤精当。

2、瘀阻腰痛

喻嘉言治张令施之弟，伤寒坏证，两腰偻废，卧床彻夜痛叫，百治不效，喻诊其脉亦平顺，痛则比前大减，乃曰：病非死证，但恐成废人矣，此证之可以转移处，全在痛如刀刺，尚有邪正互争之象，若全然不痛，则邪正混为一家，相安于无事矣，今痛觉大减，实有可忧，因谛思病情，必由热邪深入两腰，血脉久闭，不能复出，止有攻散一法，而邪入既久，正气全虚，攻之必不应，乃以桃仁承气汤，多加肉桂、附子二大剂与服，服后即能强起，再为丸服，至旬余全安。此仿仲景治结胸证附子泻心汤法，结胸者在上之证，气多，故附子与大黄同用以泻心，腰偻者在下之证，血多，故合桃仁肉桂以散腰间之血结也。后用此法治江生，二剂而愈。

震按：此人无火象见，故可多加桂、附，若不受热药则奈何！试为西昌广其义，如大黄䗪虫丸，复元活血汤，或可为桂、附分途之法乎，再如黎峒丸，山羊血、石羊胆，与针砭法，皆可一致思也。（录自古今医案按）

延按：喻氏从仲景附子泻心汤治在上之气痞，悟到用桃仁承气加桂、附，治下焦之血瘀，触类旁通，可资启发，惟误指气痞为结胸，似与仲景原意不符。

抵当汤证案（二例）

1、太阳蓄血重证

仇景莫子仪病伤寒七八日，脉微而沉，身黄发狂，小腹

胀满，脐下如冰，小便反利。医见发狂，以为热毒蓄伏心经，以铁粉牛黄等药，欲止其狂躁。予诊之曰：非其治也，此瘀血证尔。仲景云：阳病身黄，脉沉结，小腹鞕，小便不利，为无血，小便自利，其人如狂者，血证也。【注】可用抵当汤，再投而下血几数升，狂止，得汗而解。（录自伤寒九十论）

注《伤寒论·太阳篇中》129条

延按：本案叙述的证状，与太阳篇128条相符，则其狂系热在下焦与血相结所致，非热毒蓄伏心经之证，故用铁粉牛黄无效，而用本方见功。

2、太阳蓄血重证

张意田治角口焦姓人，七月间，患壮热舌赤，少腹闷满，小便自利，目赤发狂，已卅余日，初服解散，继则攻下，但得微汗，而病终不解。诊之，脉至沉微，重按疾急，夫表证仍在，脉反沉微者，邪陷于阴也，重按疾急者，“阴不胜真阳，则脉流转疾，并乃狂矣。”【注】此随经瘀血，结于少腹也，宜服抵当汤。乃自制虻虫、水蛭，加桃仁、大黄煎服，服后下血无算，随用熟地一味捣烂煎汁，时时饮之，以救阴液，候其通畅，用人参、附子、炙草，渐渐服之，以固真元，共服熟地二斤余，人参半斤，附子四两，渐得平复。

注：《素问·生气通天论》

按：此案之少腹闷满，小便自利，发狂，脉至沉微，与本条（128）条均合符节，故能以抵当汤取效。此证服本方

后继用熟地、人参等达数斤之多，是因病程较长，体力衰弱，另一方面也可以看出抵当汤药力之峻猛程度，从这里也可以体会到方后注之“不下更服”是有着深刻的意义。（录自伤寒论译释《续名医类案》）

延按：本证先猛攻，后峻补，使邪去而正不伤，足资取法。

抵当丸证案（三例）

1、伤寒蓄血

有人病伤寒七八日，脉微而沉，身黄，发狂，小腹胀满，脐下冷，小便利，予投以抵当丸，下黑血数升，狂止，得汗解。（本事方）

2、妇人腹中积块痛

常熟鹿苑钱钦伯之妻，行经九日，腹中有块攻痛，自知非孕，医与三棱、莪术多剂未应，当予抵当丸三钱，开水送下。入夜，病者在床上，反复爬行，腹痛不堪，天将旦，随大便下污物甚多，其色黄白红夹杂不一，痛乃大除。次日复诊，予加味四物汤调理而愈。（经方实验录，陈葆厚医案）

按：一案为伤寒蓄血的典型，一案为妇人杂病症瘕之类，俱用抵当丸而取效，可知治病用药，既要辨证精确，又

要灵活应变，由此更可证明认为抵当丸证没有发狂，是不够恰当的（录自伤寒论译释）

延按：抵当丸证见《伤寒论·太阳篇中》130条系用抵当汤药品，小其剂量，作丸，为峻药缓用法。体质较虚有瘀阻，不任峻攻者，或已用过攻破气血药如三棱、莪术多剂未应者，用抵当丸较稳妥无弊。

3、死血胁痛

虞天民治一人，年四十余，因骑马跌扑，次年左胁胀痛，医与小柴胡汤加青皮、龙胆草等药，不效，诊其脉，左手寸尺弦数而濇，关脉芤而急数，右三部惟数而虚，虞曰：明是死血证，用抵当丸一剂，下黑血二升许，后以四物汤加减，调理而安。（录自古今医案按）

延按：本证是血瘀而非气滞，故用小柴胡加味无效，但既认是死血，何以不用抵当汤而用丸，想考虑右三部脉数而虚之故乎，观其善后用四物汤，则此证着眼在血分可知。

伤寒治黄三方加味证案

湿热黄疸

农人张友敬，家贫人众，操作辛勤，不避风雨，自恃体健，从不惮劳。不期春候反常，时晴时雨，田中插秧锄草，日受湿热蒸蒸，夜间又贪凉取快，感受风邪。日前突然恶寒

发热，头身重痛，自服表散丹方，汗出热解，暂得轻松，仍力于田。夜又发热，头重目昏，不能起立，医处解表渗湿方，寒热稍减，反增口渴，心烦，胸中嘈杂，头常汗出，身黄如橘子色，尿短黄。诊脉滑数，舌苔黄白而腻，发热不恶寒，详参上证，是为热邪蕴郁，湿气薰蒸而成黄疸。前医之解表渗湿为不谬，其不效者，药轻病重之故。考《金匮翼》：①“黄疸……此为脾胃积热，而复受风湿，瘀结不散，湿热郁蒸，或伤寒无汗，瘀热在里所致。”指明湿热郁久，蕴而成黄，或因汗出不彻，瘀积而成，治以清热渗湿为宜。但外邪尚未尽解，亦应兼予疏散，处麻连赤小豆汤②加茵陈、苡仁，嘱服三剂。复诊：脉不浮而滑数，外热虽除，内热尚盛，疸黄如故，苔仍黄腻，不思食，尿短赤，腹胀，三日未便，再予清热渗湿，微通府气。改用茵陈蒿汤③，栀子柏皮汤④，加苍术、花粉，两日服完三剂，大便通，身黄略褪，可食稀粥半碗，能起立行动。乃于前方去大黄，每次冲服明矾末五分，经服五日，黄褪三分之二，精神饮食均佳。易茵陈五苓散⑤，加苡仁，仍照常吞服矾末，一周黄褪尽，略事清补，遂告全愈。（录自赵守真治验回忆录）

注：①《金匮翼》清尤怡在泾撰

②《伤寒论·阳明病篇》263条

③《伤寒论·阳明病篇》238条

④《伤寒论·阳明病篇》262条

⑤《金匮·黄疸病篇》

延按：后世注家对伤寒论治黄三方，不乏精辟的论述。如尤在泾云：“茵陈蒿汤是下热之剂，栀子柏皮汤是清热之

剂，麻连赤小豆汤是散热之剂。”金鉴亦云：“伤寒身黄发热者，设有无汗之表，宜用麻连赤小豆汤汗之可也；若有成实之里，宜用茵陈蒿汤下之亦可也；今外无可汗之表，内无可下之里，故惟宜栀子柏皮汤清之也。”本案根据湿热发黄之表里浅深，施用不同的治黄方剂，非笼统混施可比，所以见效，明矾末冲服方亦佳。

小柴胡汤证案（二例）

1、半表半里

孙兆治一人，伤寒五六日，头汗出，自颈以下无汗，手足冷，心下痞闷，大便秘，脉沉紧，或者以为阴结。孙曰：此即仲景所谓半在表，半在里，脉虽沉紧，不得为少阴病也。投以小柴胡汤而愈。盖四肢冷，脉沉紧，似乎少阴，然少阴多自利，不当大便鞕，况头者三阳同聚，若三阴经则至胸而还。今有头汗出，似乎阳虚。故曰汗出为阳微，然少阴额上冷汗，则为阴毒矣。故曰阴不得有汗，今头汗出，知非少阴也，与小柴胡汤，设不了了者，得屎而解，仲景虽不立方，可知其为大柴胡汤矣，此亦阳证似阴之一种也。（录自古今医案按）

延按：本证提出阳微结与纯阴结的辨证方法，并根据所出现的脉证，判断系阳微结而非纯阴结，故遵仲景法用小柴胡汤治疗。其用大柴胡汤，系从“得屎而解句”悟出。关于阳微结与纯阴结的理论阐述，可参阅全国教材《伤寒论讲义》

1964年版太阳篇下153条自明。

2、伤寒胁痛

董齐贤病伤寒数日，两胁满胀，痛不可忍或作舞豚状，许视之曰非也。少阳胆经，循胁入耳，邪在此经，故病心烦，喜呕，渴，往来寒热，默不能食，胸胁满闷，少阳证也。始太阳传入此经，故有是证。仲景云："太阳病不解，传入少阳，胁下满干呕者，小柴胡汤主之。"【注】三投而痛止，续得汗解。（录自伤寒九十论）

注：《伤寒论·少阳篇》267条

延按：本案叙述了少阳病一系列应有证状。但此条仅据胁痛一证，即用此汤者，系根据《伤寒论·太阳篇中》103条"伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。而施治的。

小柴胡汤加味证案（三例）

1、热入血室谵语

孙东宿治李悦斋夫人，胸胁大腹作痛，谵语如狂，寅卯辰三时少轻，午后及夜，痛剧咬人，昼夜不睡，饮食不进者十八日，究其故，原有痰火与头疼牙疼之疾，又因经行三日后，头疼发寒热，医以疟治，因大恶热，三四人交扇之，而两手浸冷水中，口噙水而不嚥，鼻有微衄，又常自悲自哭、

目以多哭而肿，小水直下不回，喉哽哽吞药不下，脉则左弦数，右关洪滑。孙曰：此热入血室证也，误服刚燥之剂而动痰火，以致标本交作，诸人犹谓热入血室，惟夜间谵语如见鬼，何至胸胁疼剧咬人耶，孙曰，仲景云：经水适来适断，皆作热入血室治，痛极咬人者，乃胃虚虫行求食而不得，故喉梗梗然也，即以小柴胡汤加桃仁、丹皮，而谵语减，次日以安蛔汤与服，而疼止食进。（录自古今医案按）

震按：痛极咬人，合以喉中梗梗，认为蛔饥求食，亦属偶然应验，若欲据以辨证，恐不足凭。

延按：此系热入血室兼蛔虫证，故治法如此。惟内热太甚，小柴胡似宜去甘药，再加元胡、归尾、川楝等以增强祛瘀止痛之力，至认为兼蛔而用安蛔汤，必尚有兼蛔之确据，惜未叙述明白。

2、少阳伤寒热乘肝胆

张太来妻，寒热间作，口苦咽干，头痛两侧，默默不欲食，眼中时见红影动……少阳胆气溢于肝经，目为肝窍，热乘肝胆，而目昏花，予用小柴胡汤和解少阳，加当归、香附宣通血分，羚羊角泻肝热而廓清目中，不数剂而愈。

3、少阳伤寒胆虚热乘

八女（齐之女）六岁。寒热往来，每于梦中惊叫而醒，爬入身上，且哭且怕，至十余夜，不能瞑目，将合眼就大哭大叫……余曰：此胆虚热乘，用小柴胡汤去黄芩，（未见口

苦、咽干，不用黄芩），加白茯苓、远志宁心安神，竹茹开郁，真琥珀定惊，一剂而安。

按：两案均有往来寒热，当属柴胡汤证，故投以小柴胡汤，均能药到病除。前者有口苦咽干，眼合昏花，故用全方复加宣通气血如当归、香附、泻热凉血如羚羊，而后者虽有往来寒热，但尚未有口苦咽干现象，故不用苦寒之黄芩、因有惊恐神志不宁、故加白茯苓、远志，（录自伤寒论译释《齐氏医案》）

延按：《伤寒论·少阳篇》265条，有悸而惊之文，系由吐下伤残气血。第二案的惊恐，虽不由吐下，但稚女神虚胆怯，亦属气血不足之征。

柴胡桂枝汤加味证案（一例）

失 表 坏 证

农民谢荆生，年25岁。先病感冒未解，寻又大便不利多日，但腹不痛胀。医不审虚实，频用大小承气汤，备急丸之类，愈下愈不通，病日加剧。诊脉浮而略弦，问答不乱，声音正常。自述口苦胁痛，多日未食，最苦者两便不通耳。细询左右则谓：患者日有寒热，寒时欲加被，热则呼去之，两月来未曾一见汗。头身时痛，常闻呻吟，是外邪尚未尽，幸其人体健力强，据现在证状，犹以发汗解表为急。证见脉弦口苦，胸胁满胀，病属少阳，当用柴胡和解；头身疼痛，寒热无汗，病属太阳，又宜防、桂解表。拟柴胡桂枝汤加防

风。服后温复汗出，病证显然减轻。再剂两便通行，是即外疏通内畅遂之义。遂尔进食起行，略事培补，日渐复元。（录自赵守真治验回忆录）

延按：伤寒治例，凡表里同病，里证不急的，宜先解表后治里，本证虽有大便不通现象，但无里实征兆，虽误用下剂，因其人年壮体健，表邪并未内陷，所以最后仍用和解太少法获效。

大柴胡汤证案（二例）

1、伤寒少阳证兼里实

一人病伤寒，心烦喜呕，往来寒热，医以小柴胡与之，不除。许曰：脉洪大而实，热结在里，小柴胡安能去之。仲景云："伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤，"三服而病除。（录自古今医案按）

延按：许学士治此证引仲景语见《伤寒论·太阳篇下》140条。小柴胡虽治少阳证，是病未入里，此证已有里实，脉不弦细，见洪大而实，所以须用大柴胡，才能药与病合。

2、少阳兼阳明里实

传爱川治一人，脉弦细而沉，天明时发寒热，至晚二腿汗出，手心热甚，胸满拘急，大便实而能食，似劳怯，询之因怒而得，用大柴胡汤。但胸背拘急不能除，后用二陈汤加

羌活、防风、红花、黄芩，煎服愈。

按：此证脉弦细而沉，寒热休作有时，胸满拘急，大便实，是少阳而兼阳明里实的证候，所以用大柴胡汤。柴胡苦平疏肝，肝胆相表里，胆为少阳之府，少阳枢机得转，故寒热能退；大黄、枳实苦寒以导滞通便，能去大肠结实，是解表清里的兼治方法。（录自伤寒论译释）

延按：用大柴胡汤，少阳兼里实证得解，但胸背拘急仍在，当系痰饮瘀血阻滞经络之故，观其用二陈加活血清热通经药可知也。

大柴胡汤加味证案（二例）

1、经脉动惕、潮热

吴绶治一人，伤寒未经发汗，七八日，经脉动惕，潮热来尤甚，其肉不瞤，大便秘结不行，小便赤涩，以手按脐旁鞕痛，此有燥屎也。用加味大柴胡汤下之而愈。（录自古今医案按）

延按：本证大便秘，小便赤，脐旁鞕痛，潮热，较许学士治案为甚（见大柴胡证案一）所以大柴胡汤不能胜任。此案用加味大柴胡汤，想系于方中加重大黄、枳实剂量，再加芒硝以增强攻下软坚之力。

2、湿热阻滞胁痛

吴某　男　52岁。十日前，原因不明，突感右胁隐隐作痛，日渐增剧，近日竟至局部不敢触按，身体不敢伸直。口苦而臭，渴不欲饮，食欲锐减，小便时清时赤，大便量少艰通。舌苔白腻微黄，脉沉弦数，治拟疏肝利湿。与小柴胡汤加川楝、郁金、茵陈、栀子等进退，连服四剂无效。

再诊：胁痛仍然，小便欠利，大便艰通，有里急后重感。舌苔转黄浊，脉象如前。此证前认为湿热内蕴，木郁不达，其服药未效者，恐系病重药轻之故。盖小柴胡汤虽能和解少阳，疏泄肝胆，无如此证湿热秽浊之邪盘踞已深，但事疏解，无所裨益；所加茵陈、栀子虽能清利湿热，但邪盛之时，若不配合疏导之品亦难发挥其效用。因改大柴胡合茵陈蒿汤加减。

处方：北柴胡9克　生大黄12克　黄芩9克　半夏9克　白芍9克　枳实6克　茵陈50克　栀子9克　车前草31克　郁金9克

服药后，胁痛减轻，大便畅通两次，气味奇臭，小便畅行，里急后重解除。但舌苔仍黄浊，脉象如前。湿热虽未尽除，且喜气机已转，当再步前法。

按前方再服一剂，胁肋疼痛消失，余证均除（录自伤寒论汇要分析俞长荣医案）

延按：观此案治疗经过，可见药虽对证，而力量不够，也不能达到治疗效果。

紫胡加龙骨牡蛎汤证案 一例

少阳枢机不畅

张意田治一人，戊寅三月间，发热胸闷不食，大便不通，小便不利，身重汗少，心悸而惊。予疏散消食药，证不减，更加谵语叫哕，脉弦缓，乃时行外感，……脉弦发热者，少阳本象也；胸闷不食者，逆于少阳之枢分也。少阳三焦，内合心包，不解则烦而惊，甚则阳明胃气不和而谵语；少阳循身之侧，枢机不利，则身重不能转侧；三焦失职，则小便不利；津液不下，则大便不通。此证宜以伤寒例八九日下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不能转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。【注】果愈。

注：《伤寒论·太阳篇中》110条

按：此证虽不是由于误下，但逆于少阳之枢转则相同，所以投之立效。（录自伤寒论释泽《名医类案》）

延按：《伤寒论类方汇参》云："是证也，本阴阳错杂之邪，是方也，亦攻补错杂之药，柴、桂解未尽之表邪，大黄攻已陷之里热，人参，姜、枣，补虚而和胃，茯苓、半夏、利水而降逆，龙骨、牡蛎、铅丹之涩重，镇惊，收心而安神明。"为小柴胡汤的变法。徐洄溪谓此方能下肝胆之惊痰，以之治癫痫必效。

紫胡加龙牡汤加减证案（一例）

肝郁失志

许秋菊，三旬余妇人。因先丧偶，继又殇子，悲感逾恒，兼之田畴歉收，以此郁抑寡欢渐而饮食减少，夜不安眠，甚至达旦不寐，久乃神志失守，时清时昧。服药多从癫痫治，其实非是。患者蓬头垢面，骨瘦如柴，蚩蚩向人作苦笑，或歌或哭，对人有礼貌，而大失常态。诊脉弦细，两目微红，舌苔黄腻，梦中有时乱语，大便数日一行，小便黄短。细加分析，是由肝气抑郁，胃气失调，证虽类癫痫而实非癫痫，治宜安神定志清郁调肝为主。处柴胡加龙牡汤，去参、桂，加生地、石菖卜、香附、郁金、日进二剂，四日人渐安宁。再三剂，内热已清，神志稍明，仍不时吐清痰，胸痞，间亦嗳气改进调气祛痰之加味温胆汤，（柴胡、香附、党参、黄连、甘草、桔梗、陈皮、枳实、大枣、生姜），服此六剂，志定神宁，痰少气顺，人事清楚，肌肉渐生。后用补血益气清胃安神之养血安神汤，（当归、芍药、地黄、川芎、陈皮、茯苓、白术、甘草、黄连、柏仁、枣仁）调理期月复常。（录自赵守真治验回忆录）

延按：本证用柴胡加龙牡汤加减以治类癫痫证，可证徐洄溪说之不谬，（见前页名医类案张意田案后延按），此病因

肝郁而生内热，故于本方去参、桂之壅补助热，而加生地、萝卜、香附、郁金清热凉血舒肝解郁之药，更见其善于运用古方，剪裁得当。迨病势缓解，继进调气祛痰之剂，痰少气顺后再进补益气血清肝安神之方。治法先后不紊，所以收到满意效果。

理中汤证案（三例）

1、感寒夹食

喻嘉言治袁仲卿之子，仆水救回，大热呻吟，儿科以惊风丸散与服，二日遂昏迷不醒，胸高三寸，颈软息微。喻诊之曰：脉无根，仅如蛛丝，不可为奚。以汤二茶匙，滴入口中，微有吞意，因思病虽因惊而得，其实跌仆水中，受寒湿之气而发热，胃中食物不化，当比夹食伤寒例治，乃以金石寒冷药镇坠其邪，深入脏腑，神识因而不清，其食停胃中者，得寒凉而不运，所进之药，皆在胃口之上，不能透入，转积转多，以致胸高而突，宜以理中汤运转前药，或有生机，即煎理中汤一盏，灌入喉中，大爆一口，果然从前二日所受之药，一齐俱出，胸突顿平，颈亦稍硬，但脉仍不出，人亦不醒，喻曰：此为食尚未动，关药堵塞之故，再灌前药些少，热亦渐退，乃用元明粉一味化水，连灌三次，下黑粪甚多，继以生津药调理而愈。（录自古今医案按）

延按：本证通过询问病由，知其盛寒夹食，应用辛温表散略佐消滞之剂，乃误用寒凉钳坠而致结胸，故用理中救误，俟中气转运，再用元明粉下肠中结粪，仿调胃承气之

法，先温后下，步骤井然。

又按：忆余解放初期，在家乡私人开业时，曾治一两岁之男性小儿，出麻疹时服清凉药太过，致患慢惊，面色恍白无华，吐泻肢冷，神疲息微，手足时抽搐，一派阳虚现象，但舌干乏津，不但阳虚津亦不足，用理中合生脉散愈之，（一为伤寒方，一为千金方）、是扶阳兼救津之法。

2、久　　疟

喻嘉言治中尊陆六息久疟，一日轻，一日重，食减肌瘦，困倦嗳气。嘉言云：是由饥饱劳佚所感，受伤在阳明一经，故饮食减而大便转觉艰涩者，胃病而运化之机迟也，肌肉消瘦者，胃主肌肉也，形体困倦者，胃病而约束之机关不利也，口中时时嗳气者，胃中不和而显晦塞之象也，一日轻一日重者，因时日干支之衰旺，与人身相关，故甲丙戊庚壬为阳乙丁已辛癸为阴，疟久食减，胃中之正已虚，而邪去未尽，是以值阳日助正，而邪不能胜则轻，值阴日助邪，而正不能胜则重也。当以理中汤助胃家中脘，俾得运用，则下脘之浊气，自能传入肠中，而大便不艰，不复升至胸中，而膈间宽快矣、

震按：此条议论通畅，而干支衰旺之说前人从未道及，可比昌黎之张皇幽渺矣。（录自古今医案按）

延按：对理中汤治久疟胃气虚衰机能不运之病理，分析明白晓畅，深有启发。至干支衰旺之说，存而不论可矣。

3、消　　渴

陈石金，46岁。始患伤寒未瘥，旋又伤食吐泻，服葛根桂枝汤加神曲、查肉之类，表虽解而吐泻未已。又处不换金正气散温中止呕，宽胀消食，而吐泻得止，又转口渴尿多，次数频仍，改进白虎加人参，甘露饮，六味地黄汤等，半月无进步，渐次面削肌瘦，神疲纳少，倦卧床第，不能起行。诊视时，见患者枯瘦脱形，目炯炯有神光，面唇无华，舌胖润白，脉微无力，渴尿无次，已至饮一尿一，小便清长，尿上层无油脂。病由伤寒吐泻而起，营卫已损，阴津复亏，吐泻伤脾，中焦失运，循至肺气不能下降，制约关门，肾火不能上升，蒸发津液，阴阳阻隔，上下失交，故消渴之证成。必使中焦能运，而使上下升降得宜，肺布津液，肾司蒸发，何至上渴下消，此理中汤之旨也。于是处以此方：党参18克　白术15克　干姜9克　炙草6克

五剂病始好转，口略知味，精神略振，可能缓步，又五剂，渴尿大减，接近正常。终因病过虚损，尚须大补，改与养营汤培补气血，历时兼旬始健。（录自赵守真治验回忆录）

延按：口渴尿多之消渴，用白虎加人参，甘露饮，六味地黄汤一类方剂，为医者谁不知之，迨服之不效，即傍徨无措。至用理中治渴之妙义，则理解较难，本案根据用药经过，结合面色，舌苔，脉象，认为由吐泻伤脾所致，大胆运用理中汤获效。考《伤寒论类方汇参》云："脾土虚弱，灌溉失职，不能为胃转输津液上升于口，而遂作渴，理中汤温

补脾土，津液得升，口渴乃解”。此证即本此意而立法处方也。

理中汤加味证案（三例）

1、汗下后背独恶寒

滑伯仁治一人，病伤寒，已经汗下，病去而背独恶寒，脉细如线，汤熨不应，伯仁以理中汤加姜、桂、附子大作服，外以荜拔、良姜。吴萸、桂、椒诸品大辛热药为末，姜汁调敷满背，以纸覆之，稍干即易，如是半月，竟平复不寒矣，此治法之变者也。

震按：此以热药外敷，又开一法。（录自古今医案按）

延按：仲景对背恶寒，以中和的治法，是外施灸法，内服附子汤。见《伤寒论·少阴篇》304条，临床时可参合运用。

2、患疟吐蚘

李士材治相国沈铭缜，患疟，吐蚘，闷不思食，六脉沉细。李曰：疟伤太阴，中寒蚘动也，用理中汤加乌梅三个，黄连1.5克，四剂后，胸中豁然，寒热亦减，蚘亦不吐。去黄连，加黄芪6克，生姜15克，五剂而疟止。（录自古今医案按）

延按：本证断为足太阴脾疟，吐蚘系胃寒所致，故用理中调胃而分阴阳，则疟可止，用连、梅之酸苦安蚘，则蚘自不吐，诊断用药俱精当可法。

3、伤暑夹食兼夹阴

张路玉治金鲁公，触热劳形，醉饱不谨后受凉，遂发热头痛，胀满喘逆，大汗如蒸，面赤戴阳，足冷阳缩，脉弦数无力。曰：此伤暑夹食而复夹阴也。与大顺散一服，不应，转胀急不安，因与枳实理中加厚朴、大黄，是夜更衣二次，身凉足暖而痊。

震按：此案于不谨后受凉，及戴阳阳缩足冷汗多且喘，最易认作阴证，其辨在发热头痛胀满与阴证不合，要知不谨之前，尚有醉饱之病因也，大顺散不应，转加胀满，病情易辨矣，更衣二次而痊，设误服白通四逆奈何？（录自古今医案按）

延按：本证用理中合小承气，虚实兼顾，故能便通身凉足暖而病愈。

理中汤加附子证案（四例）

1、真寒假热痢

李士材治屯院孙潇湘夫人，下痢四十日，口干发热，饮食不进，腹中胀闷，完谷不化，尚有谓其邪热不杀谷者，计服香、连、枳、朴、豆叩等，并余剂，绝谷五日，命在须臾，李诊之脉大而数，按之豁然，询得腹痛而喜手按，小便清利，此火衰不能生土，内真寒而外假热也。亟煎附子理中

汤，冷服一剂而痛止，六剂而热渐退，能食进，能服八味丸，二十余日而安。（录自古今医案按）

延按：本证亦系根据问诊和切诊，判断为真寒假热之病，故用附子理中汤，妙在热药冷服防其格拒，善后用八味丸，注重肾气，尤妙。

2、阳虚口碎从脉舍证

慎柔和尚治薛理还仆，远行忍饥，又相殴脱力，时五月初，遂发热谵语，服过补中益气及五苓散剂，不效。慎柔诊之，六脉俱无，乍有则甚细，其外证则面赤谵语口碎。一医曰：阳病见阴脉，证在死例。慎柔曰：当以阳虚从脉舍证治之。用附子理中汤，冷服二帖，脉稍见，四帖则脉有神而口碎愈矣，六帖则脉如常，但谵语未已，慎柔曰：脉气已完复而谵语不休者，胃有燥粪，以猪胆汁导之，果下燥结，谵语遂平。（录自古今医案按）

延按：本证认为阳虚，注重在问诊，远行忍饥，相殴脱力。切诊，六脉俱无，乍有则甚细。外证虽面赤谵语口碎，但内无烦渴饮冷之证，至胃有燥粪，（胃指肠部言），不用承气而用胆导法者，恐亦考虑证属阳虚，所以慎用攻下而以外导法为妥也。

又按：此证用附子理中冷服效果方好，应注意。

3、患疟元阳衰脱

喻嘉言治袁继明，素有房劳内伤，偶因小感，自煎姜葱汤表

汗，因而发热三日，变成疟疾。喻诊其脉，豁大空虚，且寒不成寒，热不成热，气急神扬，知为元阳衰脱之候。因谓其父曰：令郎光景，窃虑来日疟至，大汗不止，难于救药，今晚宜用人参62克，煎浓汤，预服防危，渠父不以为意，次日五鼓时，病者便觉精神恍惚，觅得参至，疟已先发矣，喻甚傍徨，恐以人参补住疟邪，虽救急，无益也。只得姑俟疟势稍退，方与服之，服时已汗出沾濡，顷之，果然大汗不止，昏不知人，灌药难入，直至日暮，白沫转从大孔遗出。喻喜曰：白沫下行，可无恐矣。但内虚肠滑，独参不能胜任，急以附子理中汤，连进四小剂，人事方苏，能言，但对面谈事不清，门外有探病客至，渠忽先知，家人惊以为祟。喻曰：此正神魂之离舍耳。吾以独参及附子理中驷马之力追之，尚在半返未返之界，以故能知宅外之事，再与前药二剂而安。

震按：高鼓峰治新安程结先子病疟，皆从此案描出，但每日辰时大寒，午时大热，热即厥，两目直视，不能出声，颏脱，涎水从口鼻涌出不止，日流数升，至丑时始得汗解，饮食不进，昏冒欲绝，其为虚甚，龙易识耳，惟以大剂参、芪、桂、附而兼熟地，是宗景岳法，与喻案不同。（录自古今医案按）

延按：本证患疟而致元阳虚脱，根据脉证当补而兼温无碍。其服药方法，先进独参汤，后用附子理中汤，小剂连进，以接续一线欲脱之阳，其解积白沫下行认为病之转机，对能知门外之事，认为神魂之离舍而非有鬼神为祟，具见卓识。

4、中寒误用清凉

吴球治一人，暑月远行，渴饮泉水，至晚以单席阴地上睡，顷间，寒热，吐泻不得，身痛如刀刮。医曰：此中暑也，以黄连香薷饮及六和汤，随服随厥。吴诊其脉细紧而伏，曰：此中寒也。众皆笑曰：六月中寒，有是事乎。吴曰：人肥白，素畏热，好服黄连及益元散等凉剂，况途中饮水既多，又单席卧地，寒邪深入，当以附子理中汤，大服乃济，用之果效。

震按：中寒一门，喻嘉言论之最精，然此证易辨，无甚诡幻，惟内寒外热格阳戴阳者，不可认错，此又当于伤寒门细研之，盖中寒与伤寒不同也。（录自古今医案按）

延按：此暑月中寒证，由避暑乘凉饮冷过度所致。医不察致病原由，妄用治暑套药，故不效而厥。用附子理中汤是对证施治，不为时令所拘。后世创阴暑之名，其说似是而非，王孟英氏已辟其谬，可参阅其医案及温热经纬诸书自明。

四逆汤证案（一例）

经期受寒厥逆

苏某妻、三十余岁。月经期中不慎冲水，夜间忽发寒战，继即沉沉而睡，人事不省。脉微细欲绝，手足厥逆。当及针人中及十宣穴出血，血色紫黯难以挤出。针时能呼痛，并一度苏醒，但不久仍呼呼人睡。此因阴寒太盛，阳气大

衰，气血凝滞之故。急当温经散寒挽扶阳气。拟大剂四逆汤一方。

处方：炮附子25克　北干姜12克　炙甘草12克　水煎嘱分四次温服，每半小时灌服一次。病者家属问：此证如此严重，为何把药分作四次，而不一次服下使其速愈？我说：正因其症状严重，才取"重药缓服"办法，其目的为使药力相继，缓缓振奋其阳气，而驱散阴寒，譬如春临大地，冰雪自然溶解；如果一剂顿服，恐有"脉暴出"【注】之变，譬如突然烈日当空，冰雪骤解，反致弥漫成灾。服全剂未完，果然四肢转温，脉回，清醒如初。（录自伤寒论汇要分析，俞长荣医案）

注见《伤寒论·少阴病篇》315条

延按：此案阐述热药重剂缓服的理由，颇值得令人玩味。

又按：四逆汤方附子系生用，据俞氏经验云用炮附子亦具同等效力。

四逆加人参汤证案（四例）

1、阴寒挟暑

张路玉治范振麟，大暑中，患厥冷自利，六脉弦细芤迟，按之欲绝，舌色淡白，中心黑润无苔，口鼻气息微冷，阳缩入腹，而精滑如冰，问其所起之由，因卧地昼寝受寒，是夜连走精二度，忽觉烦胀如山，坐起晕倒，便四肢厥逆，腹痛自利，胸中兀兀欲吐，口中喃喃妄言，与温温之证不

殊，医者认为停食感冒，与发散消导药，服后胸前头项汗出如漓，背上愈加畏寒，而下体如冰，一日昏愦数次，此阴寒挟暑，入中手足少阴之候。缘肾中真阳虚极，所以不能发热，遂拟四逆加人参汤，用人参30克，熟附9克，炮姜6克，炙甘草6克，昼夜兼进，三日中进六剂，决定第四日寅刻回阳，是日悉屏姜、附，改用保元，人参15克　黄芪9克　炙草6克　加麦冬6克　五味子3克　肃清膈上之虚阳，四剂食进，改用生料六味加麦冬、五味，每服用熟地25克，以救下焦将竭之水，使阴平阳秘精神乃治。（录自古今医案按）

延按：本证通过问诊而知其阴寒挟暑，治法先回阳，后救阴，妙在药剂昼夜兼进，三日中进六剂，始克挽回此危难之证。

2、假热真寒

喻嘉言治徐国珍，伤寒六七日，身热目赤，索水到前，复置不饮，异常大躁，门牖洞启，身卧地上，辗转不快，更求入井，一医急治承气将服。喻诊其脉，洪大无伦，重按无力。乃曰：是为阳虚欲脱，外显假热，内有真寒，观其得水不欲咽，而尚可咽大黄、芒硝乎，天气懊蒸，必有大雨，此证顷刻一身大汗，不可救矣。即以附子、干姜各15克　人参9克　甘草6克煎成冷服，服后寒战戛齿有声，以重棉和头覆之，缩手不肯与诊，阳微之状始著，再与前药一剂，微汗，热退而安。（录自古今医案按）

延按：此病用四逆加人参汤以急救其阳兼顾其阴，妙在

热药冷服，庶无格拒之虞。

3、慢惊风

汤儿5岁。禀弱多病，中秋节日，恣食肉面，次日腹胀呕泻，医作伤食治，以体虚难任克伐，进以消补兼用之大安丸改汤服，腹泻转剧，呕亦未止，乃父视为药误，易医认证属虚，处温脾健胃之六君子汤，呕泻立止，认为效，续进数剂，因而腹胀如鼓，痛不可忍，医又认为实证，不顾患儿体质，贸然以大承气攻之，胀痛虽已，而腹泻不止矣。随见神疲气短，汗出肢厥，手足不时抽搐，缓而无力，显示种种之危象。余视儿面色清惨，息微目合，关纹隐微难见，抽搐乏力，启视其目，神光尚好，许其可治。即处四逆加人参汤以救垂绝之阴阳，急煎频灌，四时尽二剂。夜半阳回，肢温搐停，汗收泻止，有时呻吟。次晨复诊，关纹清淡可见，神清能言，不能坐立，此由攻伐太过，元气大伤，只应益气补脾，徐图恢复，师理中汤之意而易其分量。

处方： 党参15克　白术12克　干姜3克　炙草6克　加黄芪、补骨脂各9克

日服一剂，历时半月，未易方而复常。（录自赵守真治验回忆录）

延按： 五岁小儿，体弱伤食致病，与大安丸作汤，消补兼行，似无大误，服后仍然吐泻，当系积滞疏通之故。不应遽用六君之温补，与大承气之寒泻，以致阴阳两伤，处四逆加参以挽救垂绝之阴阳，是救逆之法。因吐泻而脾胃受伤，

所以最后仍师理中汤意以收功。

4、慢惊风

王香山次儿，3岁。病吐泻失治，半日间病转剧，吐如涌，泻如注，旋又搐搦，继则肢厥神昏，气如悬丝，认为不治……吾师蔡仁山经其门邀诊，见儿仰卧地上，肢厥如冰，关纹不见，以手掐人中，不呻；又掐合谷，亦不呻。呼吸若有若无，抚心有微热，重手按其腹，儿目忽起，神光晶莹，切足三部脉亦不显。病虽危，神光未散，尚有一线生机。先以艾灸气海、关元、天枢、阳强及两足三里诸穴，并儿脐填满食盐，切生姜薄片，戳细孔无数，置盐上，再放艾团烧之，作急救，方处四逆加人参汤。

党参18克　生附12克　干姜9克　炙草6克　急火浓煎。

陆续灌下，尚能咽，两时内服完二煎。无转变，接进二剂，约四时许，身肢转温，目能启视，不吐不泻，气虚不能言，大有好转，接服黄氏理中汤三剂调理即愈。（录自赵守真治验回忆录）

延按：慢惊之形成，亦由吐泻损脾及肾造成亡阳脱阴之危候。此案得生处，在神光未散，五脏之精未绝，尚有一线生机。治法外灸气海，关元等穴以固下焦之阳，内服四逆加参，以扶阳兼救阴，内外同治，配合得法，故能转危为安。

四逆散证案（一例）

（夹食伤寒）

吴聚群女，发热头昏，目珠上视，四肢逆冷，然唇燥尿短，病情已露于外，医者泥其发厥，更见其软弱困倦，欲以灯火姜附急施，余止之，因辨之曰：此夹食伤寒证也。四肢为诸阳之本，因食停胃中，加以新寒外入，以致胃气抑郁不能四达，故发厥而昏沉，乃大实有羸状即此类也。且既无吐泻之因又非汗下之后，此先热后厥，明是热深厥深之病，安得认为阴症耶。以木香槟榔丸一剂，下去胶粘之物一团，而人事遂醒，但厥回复厥，更以四逆散升散表邪，推泄里热，复微热微汗，而诸逆悉解。（录自谢映庐医案）

延按：四逆散见《伤寒论·少阴病篇》318条，是治阳郁不甚而四逆之方。方中柴胡升阳，白芍敛阴，枳实泄滞气，甘草缓中州，令伏邪升散四达。本案先用下食积之槟榔丸，后用升散兼通泄之四逆散，使食积寒邪随之两解，所以奏功。

白通汤证案（一例）

（阳虚头痛）

彭君，患头痛五年，凡疏散补泻之药，尝之殆遍，鲜

效，迄今头隐作痛，乍止乍作，恒畏寒，喜戴帽，或厚带缠结，略觉宽解一时，不过人日清瘦，而饮食如常，未尝急治。诊其脉细数无力，两尺犹虚，头痛喜热敷，肢寒身冷，舌白润无苔，尿清长，大便溏薄，脉证参合，乃系阴寒之气逆冲脑海，而无阳气以守之，故阴盛阳衰，证为阳虚头痛。本证阳虚脾弱，拟用：黄芪18克　白术12克　乌附9克　肉桂6克　细辛3克

四剂，病未衰，惟痛时较昔减短，畏寒则如故。思证属虚寒，理应温补而效，其不效者，或通阳药中参有补剂，反制其肘而不能发挥回阳威力。因改拟白通汤，重用生附以起下焦之阳，倍干姜大温中焦之气，葱白引阳气上通于脑以驱阴寒，浊降清升，病当自愈。服药后，即觉一缕热气由下而上，达心胸则扩然开朗，通头脑则痛止神清，连进三帖，五年沉疴顿即霍然，后用温阳益肾药进退调复。（录自赵守真治验回忆录）

延按：观此案而始恍然于阳虚头痛，用温而兼补之品，虽有小效而不能彻底，继进温通之剂，效乃大显，案中解释温补效缓之故，颇赖人深思。

通脉四逆汤加童便证案（一例）

（伤寒变证）

王新玉，伤于风寒，发热怕冷，身疼汗出，服表散药未愈。转增腹痛泄泻舌白润，口不渴，小便清利，一变而为太

阳太阴并病。用时方平胃散加防风、桂枝，不惟前证未减，反益心下支结，胸胁满痛，口苦烦渴，再变为太少二阳及太阴诸病矣。《伤寒论》中之柴桂干姜汤颇合，方未服。另医认为表实里热迭施汗下，致漏汗洞泄，息短偃卧，病势转危，诊其脉微欲绝，四肢厥逆，汗泻未已，不时转侧手扰，此属阴阳垂绝之象，亟宜通脉四逆汤挽将绝之阳，配童便敛将尽之阴，以策万全。

处方： 附子31克 干姜46克 炙草15克 浓煎，冲童便少许。

频频灌下，自晨迄暮，尽二大剂，泻汗遂减。当子夜阳回之时，汗泻全止，身复发热，是阴复阳回之兆。按脉浮缓无力，阴阳将和，邪气外透，乃煎桂枝汤加人参续进，益气解肌，二剂热退人安。后以补脾胃和气血调理复元。（录自赵守真治验回忆录）

延按： 本证叙述了伤寒病转变经过和误治后阳陷入阴的危候，经救误后复从阴出阳的转机，认证确切，治法精当，故能转危为安。

茯苓四逆汤证案（一例）

（大汗亡阳）

谭长春，男，45岁。患疟疾，经治多日未愈。曾几何时，又突发热不休，但口不渴，喜拥被卧，神疲不欲动，此

为病久正虚之证，治宜温补，医者不辨证脉虚实，只拘泥于翕翕发热而用麻桂妄汗之。遂致漏汗不止，身不厥而外热愈炽，惟蹬卧恶寒，厚被自温，不欲露手足，声低息短，神衰色惨，证情严重，病家延诊，至时，人已不能言，汗犹淋漓，诊脉数大无力，面赤，身壮热，舌白润无苔，不渴不呕，审系阴寒内盛阳气外格，属诸戴阳一证。治宜回阳抑阴，阳回则阴和，阴阳和则汗敛也。因思《伤寒论》中之通脉四逆汤及茯苓四逆汤，皆回阳方剂，若以汗多亡阳而论，则通脉四逆又不如茯苓四逆汤回阳止汗之力大，遂用大剂茯苓四逆汤以图挽救。

处方： 茯苓25克　生附18克　干姜15克　野参12克（另蒸兑）　炙草9克煎好，另加童便半杯冲服。

上方实系通脉四逆，茯苓四逆两方化裁而合用之。一日夜连药三帖，午夜发生烦躁，刹那即止，渐次热退汗停，按脉微和有神。次日口能言一二句，声音低微，气不能相续，此时阳气虽回，气血犹虚，改进十全大补汤温补气血。后又随加破纸、益智、巴戟、杜仲等温养肾元，服药半月，病体全复。（录自赵守真治验回忆录）

延按： 茯苓四逆汤见《伤寒论·太阳病篇中》69条。通脉四逆汤见《伤寒论·少阴病篇》317条。本证大汗亡阳，不用通脉四逆，而用茯苓四逆者，因此证大汗，不但亡阳亦将竭阴，故不宜纯刚之剂，恐有格拒之虞，而宜用扶阳固脱救液，刚中兼柔之剂也。

真武汤证案（二例）

1、阳虚发热

滑伯仁治一人。七月，病发热，或令服小柴胡汤36剂……未尽二剂，则升发太过，多汗亡阳，恶寒甚，筋惕肉瞤。视其脉细欲无，以真武汤进七八服稍愈，更服附子七八枚乃愈。

按：此案之过汗亡阳颇为典型，恶寒，肉瞤筋惕，都是阳虚之征，服真武汤后又服附子，足证本条还以亡阳为主，水气为次，所以治疗亦以壮阳为主，导水为辅，但得离照当空，则阴霾自散。（录自伤寒论译释《名医类案》）

延按：真武汤方一般伤寒论注家大都认为系误服大青龙汤不当引起亡阳证的救误之方，本案则为服小柴胡汤不当而导致多汗亡阳，想患者平素必属虚寒体质，虽小柴胡号称和解之剂，但方中柴胡升散，黄芩苦寒，实非所宜，可见处方用药必须辨证精确，不能草率从事。

2、阳虚汗出

申瑞林，久病之后，体气已虚，不慎风寒，又染外感，只宜培补剂中佐少许表药，殊不能视同日常表证治之。前医竟用麻黄汤发汗，因之大汗不止，头晕目眩，筋惕肉瞤，振振欲瞤地，小便难，肢微拘急，证状甚危。余见其人神志尚清明，脉现细微，汗淋漓未休，此由峻发之后，卫气不固，津

液大伤，肾气亏竭而小便难，血不荣筋而肢拘急，阳虚则水气泛逆，冲激于上，故振振而眩仆，是纯一阳虚之真武汤证，为水逆之重者。若不如此辨认，泛用漏汗之桂枝加附子汤，虽能回阳而不钲水；如用苓桂术甘汤，虽能钲水而不回阳，皆属本证前阶段轻者浅者言之，至阳虚水逆之本证，则以真武汤为适合，应大量以进。

处方：附子15克 白术 白芍各12克 茯苓25克 生姜15克

并用五倍子研末醋伴成饼，敷帖脐孔，布条捆扎，又用温粉扑身。

连进二剂，汗渐止，再三剂，不特汗全收，即眩晕拘急尿难诸候，亦均消失。后用归芍六君子汤加补骨脂、巴戟、干姜调理培补。（录自赵守真治验回忆录）

按语：本案既有大汗不止，小便难，四肢微急之桂枝加附子汤证，又有头晕目眩之苓桂术甘汤证及筋惕肉瞤，振振欲擗地之真武汤证。独选用真武汤者。诚如案中自注所云，上两方只能治初期阶段轻浅之阳虚水气为病。此证由其人体气素虚，又经久病之后，不但阳虚而且水气泛溢，非用大剂真武壮元阳以消阴翳，逐留垢以清水源，兼钲摄之温方不可。

真武汤加味证案（一例）

（虚寒气喘）

张仁华，男，48岁。自幼有咳痰痼疾，每值隆冬辄发，困苦异常。今冬感寒增剧，咳嗽喘急，短气痞闷，腹下动

悸，恒至少腹上冲心，倚息不得卧。医认脾肺虚寒，气不固摄，疏苓桂味甘姜辛汤，温肺降逆，服五剂无变化。更苓桂术甘汤加苏子、干姜，温脾利水，降气温中，仍无进展。时经月余，身体日虚，人清瘦，脉细微，手足清冷，咳喘不卧，痰多气促，声低息短，能坐不能起，起则振振欲摔地，气时上冲，幸神志清明，能吃粥半碗，治从顾及肾脏着眼，用真武汤温阳钲水，加姜、辛、味暖肺敛气，加枸杞、益智、破纸补养肾元，服十剂病不减。乃将真武汤加重分量：

处方：茯苓25克　白术15克　乌附9克　生姜　芍药各12克用都气丸18克分两次吞服。

又进五剂，病如故。忆黑锡丹大温脾肾，钲纳元阳，为虚寒喘促之圣药。因是再以真武汤改配黑锡丹，每日三钱，日进二剂，当晚喘减气平，能睡一二小时。次日复诊，脉起有力，喘咳大减。嘱原药再进，持续半月，诸证皆退，精神转好。后以肾气丸改汤，六君子汤加破故纸、芦巴间服，调理复元。（录自赵守真治验回忆录）

延按：此证反复曲折，初用温化脾肺水饮方剂，继用温肾化水方剂，均无显效，终用真武汤配黑锡丹始发挥疗效。考黑锡丹载于《太平惠民和剂局方》有升降阴阳，坠痰定喘之功，较都气丸力猛，故能愈此沉寒痼疾也。

猪肤汤证案（一例）

（阴虚发热咽痛）

张路玉治徐君育，素禀阴虚多火，且有脾约便血证，十

月间患冬温，发热咽痛，里医用麻黄、杏仁、半夏、枳、橘之属，遂喘逆，倚息不得卧，声飒加哑，头面赤热，手足逆冷，右手寸关虚大微数，此热伤手太阴气分也，与姜葳、甘草等药不应，为制猪肤汤一瓯，令隔汤顿热不时挑服，三日声清，终剂而痛如失。（录自古今医案按）

延按： 本证阴虚多火之体，患发热咽痛，误用辛散燥热药品，使肺阴更伤，声飒加哑，肺失肃降，头面赤热，阳不畅达，手足逆冷，故用猪肤汤凉润之剂，血肉之品绞草根树皮其功更优，所以收效。

黄连阿胶汤证案（二例）

1、妊娠咽痛下血

张路玉治郑墨林室，素有便红，怀妊七月，正肺气养胎时，而患冬温，咳嗽咽痛如刺，下血如崩，脉较平时反觉小弱而数，此热伤手太阴血分也，与黄连阿胶汤二剂，血止后，去黄连，加姜葳、桔梗、人中黄，四剂而安。（录自古今医案按）

延按： 此证上则咽痛，下则便血，用黄连阿胶汤之降火养阴为治，总不出热伤手太阴范围，以喉为肺之系，大肠与肺相表里也。

2、少阴伤寒邪从热化

曾丽常，34岁。辛苦异常，日夜劳瘁，一经感寒，邪传

少阴，即从火化。一身手足壮热，不能语言，舌黑且燥，脉微细而数……凡操劳者病入少阴，从热化者多，从寒化者少，今一身手足壮热所谓火旺生风，风淫末疾也。少阴肾脉夹喉咙，萦于舌底，其火一升，故舌强不能言，舌黑者，现出火极似水之色也。黄连阿胶汤主之。方用黄连、黄芩之大苦大寒以折之，白芍之苦平以降之，又取鸡子黄、阿胶气血有情之物，交媒其水火，则壮热退而能言，热退而舌不黑矣。

处方：黄连12克　阿胶9克　黄芩3克　白芍6克　鸡子黄2枚

四味先煮三物去渣，纳阿胶烊化尽，后纳鸡子黄温服。

初服二剂，病势渐平，再服一剂，诸证皆退。惟两脚拘挛，后服白芍15克　甘草9克，一剂而瘥，以芍甘能补血，则筋得所养，筋舒则拘挛自除。

何廉臣按：少阴伤寒，有传经直中之分，直中者多从水化，浅则麻附细辛汤证，深则四逆汤证。传经者多从火化，今因津枯热炽，舌黑燥而不得语，以黄连阿胶汤泻南补北【注】，确是对证处方，终用芍药甘草苦甘化阴，养血舒筋，亦属长沙正法。（录自全国名医验案类编，曾月根医案）

注：《难经·七十五难》“经言东方实，西方虚，泻南方，补北方。

延按：传经为热，直中为寒，并非绝对如此，故廉臣先生按语下一多字，足见斟酌，至用芍药甘草汤治脚拘急，系借用《伤寒论·太阳篇上》29条中方，但用得非常恰当。

当归四逆汤证案（二例）

1、厥疝

文学骆元宾，十年患疝，形容枯槁，李士材视之，左胁有形，其大如臂，以热手握之，沥沥有声，甚至上攻于心，闷绝者久之，热醋蒸炙方苏；曰：此经所谓厥疝也，【注】用治疝当归四逆汤，半月积形渐小，更以八味丸间服，半载不辍，积块尽消而不复发矣。

注：《素问．五脏生成篇》"黄脉之至也，大而虚，积气在腹，中有厥气，名曰厥疝。"（录自古今医案按）

延按：本证当属血虚寒疝，借用此方治疗甚当，如觉药力缓，可加入吴萸、生姜以增强温散之功。

2、厥阴腹痛

王志耕乃郎，半岁。夜半腹痛，啼哭不已，以热手重按其腹，似觉哭声稍可，久之仍否，延诸幼科，无非行气消食，误治两日，目珠上瞪，四肢微搐，余视其面色赤中带青，目中白珠颇蓝，手足指尖略厥，小水直无，指纹透甲。详推此证，原是寒邪入里，意拟姜、附通阳，然细察面色唇舌二便，又非无阳可比，倘辛热误用，而稚阳之质，势必血燥津涸，愈增筋掣瘛疭，因思肝藏血，寒伤营，非养血通脉，寒何由解，痛何以除，先以灯火烙腹，疏通凝寒，以当

归四逆汤，一剂豁然。（录自谢映庐医案）

延按：当归四逆本治血虚寒厥之方，柯韵伯谓为厥阴之表剂。本案借用以治小儿血虚寒滞腹痛，避姜、附之燥，用归、芍之润，使寒去而血不伤，恰当可法。

当归四逆加茱萸汤证案（一例）

（妇人缩阴证）

刘妇，年四旬余。体素虚弱，某日农作过劳，傍晚归途遇雨，衣服尽湿，不甚介意。晚间又经房事，而风雨之夜，寒气砭骨，夜半时起入厕，未久，睡感寒甚，数被不温，少腹拘急绞痛，次第加剧，待天将明，阴户遽现紧缩，自觉向腹中牵引，冷汗阵出，手足厥冷，头晕神困，不能起立，服药鲜效。诊脉微细，舌润不渴，乃阴寒之证，书当归四逆加茱萸汤，一日服完两大剂，并以艾灸气海、关元十余炷，又锡壶盛开水时烫脐下。次日愈。（录自赵守真经验回忆录）

延按：本案根据脉证认为阴寒，服当归四逆加茱萸汤确系对证，妙在内服温药，外更辅以灸法和热敷法，更能增强疗效。

干姜芩连人参汤证案（一例）

（胃病呕吐）

林某，50岁，患胃病已久。近来时常呕吐，胸间痞闷，

一见食物便产生恶心感，有时勉强进食少许，有时食下即呕，口微燥，大便溏泻，一日两三次，脉虚数。与干姜苓连人参汤。

处方：潞党参15克　北干姜9克　黄芩6克　黄连4.5克水煎，待稍和时分四次服。

本案属上热下寒，如单用苦寒，必致下泄更甚；单用辛热，必致口燥、呕吐增剧。因此只宜寒热苦辛并用，调和其上下阴阳。又以素来胃虚，且脉虚弱，故以潞党参甘温为君，扶其中气。药液不冷不热分作四次服，是含"少少以和之"①，之意。因胸间痞闷热格，如果顿服，虑药被拒不入。

服一剂后，呕吐泄泻均愈。因病者中寒为本，上热为标；现标以愈，应扶其本。乃仿内经"寒淫于内，治以甘热"②之旨，属病者购生姜、红枣各一斤，切碎和捣，于每日三餐蒸饭时，量取一酒盏，置米上蒸熟，饭后服食。取生姜辛热散寒和胃气，大枣甘温健脾补中，置米上蒸熟，是取得谷气而养中土。

服一疗程，（即尽两斤姜枣）后，胃病几痊大半，食欲大振。后病又照法服用一疗程，胃病因而获愈。（录自伤寒论汇要分析愈长荣医案

注：①《伤寒论·阳明病篇》253条

②《素问·至真要大论》

延按：本证与《伤寒论·厥阴病篇》358条病机相符，虽彼因误施吐下，此由素禀虚寒，但均属上热中寒所致，故用此汤见效。案中解释服药法最妙，值得注意。至善后调理之

方，仅取果类之大枣、菜类之生姜，辛甘配合，补中健胃，相得益彰，药味虽简，久服无弊，无以平淡而忽之。

麻黄升麻汤证案（二例）

1、上热下寒

张路玉治陆中行室、年20余，腊月中旬，患咳嗽，捱过半月，病热少减，新正五日，复咳倍前，自汗体倦，咽喉干痛，至元夕，忽微恶寒发热，明日转为腹痛自利，手足逆冷，咽痛异常，又三日则咳唾脓血。张诊其脉，轻取微数，寻之则仍不数，寸口似动而软，尺部略重则无，审其脉证，寒热难分，颇似仲景厥阴例中麻黄升麻汤证。盖始本冬温，所伤原不为重，故咳至半月渐减，乃勉力支持岁事，过于劳役，伤其脾肺之气，故咳复甚于前，至望夜忽憎寒发热，来日遂自利厥逆者，当是病中体，忽感寒邪之故，热邪即伤于内，寒邪复加于外，寒闭热邪，不得外散，势必内奔而为自利，致邪伤少阴厥阴，而作咽喉不利，唾脓血也。虽伤寒大下后，与伤热后自利不同，而寒热错杂则一，遂与麻黄升麻汤，一剂，肢体微汗，手足温暖，自利即止，明日诊之，脉亦向和，嗣后与异功生脉合服，数剂而安。（录自古今医案按）

延按：本案由病者体虚，感受冬温，忽冒寒邪，寒闭热郁，不得外散，用麻黄升麻汤者，重在清解里热，兼升发郁阳也。

2、上热下寒

陈逊斋治李梦如子，曾二次患喉痰，一次患溏泻，治之愈。今复患寒热病，历十余日不退，邀余诊，切脉未竟，已下利二次，头痛，腹痛，骨节痛，喉头尽白而腐，吐脓样痰夹血，六脉浮中两按皆无，重按亦微缓不能辨其至数，口渴需水，小便少，两足少阴脉似有似无，诊毕无法立方，且不明其病理，连拟排脓汤，黄连阿胶汤，苦酒汤，皆不惬意，复拟干姜芩连人参汤，终觉未妥，又改拟小柴胡汤加减，以求稳妥，复询其父，病人曾出汗几次？曰：始终无汗，曾服下剂否？曰：曾服泻盐三次，而至水泻频仍，脉忽变阴，余曰：得之矣，此麻黄升麻汤证也。（以未曾汗解而攻其里，表热内攻，故上热，下之里虚，故下寒。）病人脉弱易动，素有喉痰，是下虚上热体质，新患太阳伤寒而误下之，表邪不退，外热内陷，触动喉痰旧疾，故喉间白腐，脓血交并。脾弱湿重之体，复因大下而成水泻，水走大肠，故小便不利。上焦热甚，故口渴，表邪未退，故寒热头痛骨节痛，各证仍在。热闭于内，故四肢厥冷。大下之后，气血奔集于里，故阳脉沉弱，水液趋于下部，故阴脉亦闭歇。本方组织，有桂枝汤加麻黄，所以解表发汗，有芩、术、干姜化水，利小便，所以止利，用当归助其行血通脉，用黄芩、知母、石膏以清热兼生津液，用升麻解咽喉之毒，用玉竹以祛脓血，天冬以清利痰脓，明日，服此方……后果愈。

按：此案翔实可靠，据所述证候，确实非常复杂，无怪

屡医不效。陈氏开始也并未能识得本证，足见审证之难。从案中可以看出，确诊本证的关键，在于问诊，通过曾出汗几次之间，得悉始终无汗；通过曾服下剂否之间，得悉曾服泻药三次，从而测知该证病变的由来。以未曾汗解而攻其里，表热内攻，故上热；下之里虚，故下寒，因之投以麻黄升麻汤，效如立竿见影，足证本方药品虽多，决不是杂凑，相反，寓有精当的意义。（录自伤寒论译释）

延按：此证用麻黄升麻汤之着眼点，在于出现的各种错综复杂的病变，都属表邪闭阻，没有外解，是阳郁而非阳虚，故用清解热毒兼透表的药品。

白头翁汤加味证案（一例）

（热利下重）

欧某，男，48岁。下痢已十余日。始则小腹疼痛，里急后重，大便呈粘液状；近日所下多脓血，日行20余次，肛门有灼热感。口燥而苦，时时欲呕。饮食尚可。小溲短赤而热。此系湿热内聚胃肠。挟肝胆相火上逆，则口燥苦而欲呕；下迫则为赤痢。饮食尚可，知非噤口痢。治从清热利湿，兼与疏肝利胆。

处方：小柴胡汤62克、白头翁12克　秦皮9克　黄连黄柏各6克

复诊：大便次数减为一日十余次，里急后重稍差，余症同前。

处方：白头翁12克　秦皮　柴胡　赤芍各9克　大黄12克　黄芩　枳壳　半夏　黄柏　生姜各6克　黄连4.5克

连服两剂，下痢基本控制，腹痛欲呕均瘥。

本例赤痢，里急后重，肛门灼热，为颇典型之白头翁汤汤证。但因口苦时时欲呕，故初诊用白头翁汤治痢，配合小柴胡汤除呕。服后，下痢证虽有减轻，但口苦欲呕仍在。知系肝胆郁热亢盛，小柴胡汤力有未及，故于复诊时，仍主用白头翁汤，而改小柴胡为大柴胡汤。服两剂果然获效。（录自伤寒论汇要分析，俞长荣医案）

延按：白头翁汤治热利下重，《伤寒论，厥阴病篇》370条已有明文记载。本证因肝胆郁热亢盛，故辅以大小柴胡汤，来增强疏肝利胆，荡涤肠胃湿热之力。其得效仍在第二方大柴胡合白头翁汤并用。

加减乌梅丸证案（一例）

（腹中虫痛）

肖大楚，老农。腹中攻痛，上下窜扰，频吐清涎，痛剧则肢厥，数月一发以为常。自疑寒积，煎姜艾汤冲胡椒末，往往获效。冬月不慎风寒，经医用解表及消导药，表解而腹痛益增，走注不定，甚至昏厥，医又认为大建中汤证，服药痛仍未止。医院检查为蛔虫集结肠间，用山道年杀虫药，虫不下，亦不便，痛视前增剧。又认为肠绞结，须开刀。患者惧而求治于中医，其脉参差不一，乍大乍小，面色萎黄，并

有白斑，唇红，舌白润，口不渴，肢冷吐涎，腹中攻痛，发作有时，此为虫证，应作虫治。但病久体虚，阳微阴盛，不宜专于驱虫，应扶阳温中佐以杀虫，乌梅丸加减。

处方：乌梅15克　干姜　党参　附子　肉桂　当归　蜀椒各9克　细辛3克　去苦寒之连、柏、加杀虫之槟榔、雷丸各9克　雄黄末2.5克（兑）　并用赭石31克。

方意在用温补药以增强胃肠，用杀虫药以驱虫内散，使不结聚，复用重坠药乘势逐其下行，则肠结可解，大便能通，虫亦难安，势将随便排出矣。水煎顿服，一日两剂，稀便数次，杂下死蛔20余条，痛减肢温，脉现细弱，尚属阳微不振，气血大虚，于前方去杀虫药，又五剂，痛解全安，随用十全大补汤调理。（录自赵守真经验回忆录）

延按：乌梅丸非杀虫之剂，乃温中安蛔之剂，用之驱虫，必于方中加入杀虫药，效果始显。本案先因虫积肠间，不得不事驱虫。因病久体虚，阳微阴盛，所以方中去苦寒之连、柏加杀虫之槟榔、雷丸、雄黄，重坠之赭石引之下行，迨虫积渐去，而阳微不振，继仍用去苦寒药和杀虫药之乌梅丸，病邪既尽，终用十全大补汤调养气血以善后。

吴茱萸汤证案（一例）

（痰厥头痛）

刘翁，年古稀，体矍铄，嗜茶，时吐清涎，每届天候转变，遂发头痛，而以巅顶为烈，服温药则愈。近因家务烦

劳，头痛较增，咳剧涎多，不热不渴，畏寒特甚，切脉细滑，舌润无苔，口淡乏味。从其头痛吐涎畏寒等象观测，由于阳气不振，浊阴引动肝气上逆之所致。且年高体胖，嗜茶增湿，胃寒失化，水泛成痰，外表虽健，而内则虚寒痰凝也。治以吴茱萸汤温中补虚，降逆行痰。

处方：党参25克　吴萸6克　生姜15克　大枣五枚

连进三帖，头痛吐涎渐减，而小便清长，较昔为多，此缘阴寒下降，阳气上升，中焦得运，决渎复常耳。原方再进四帖，诸证尽失。改用六君子汤加干姜、砂仁温脾益气，善后调理。（录自赵守真治验回忆录）

延按：吴茱萸汤在《伤寒论》中凡三见。一为阳明病篇205条。“食谷欲呕，属阳明也……。”一为少阴病篇309条。“少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者……。”一为厥阴病篇377条。“干呕，吐涎沫，头痛者……。”三条俱有呕吐的主证，俱用吴茱萸汤治疗。本案借用此方以治痰厥头痛，考其致痛病因。由于老年阳气不振，嗜茶增湿，水泛成痰，浊阴引动肝气上逆所致。主以温中降逆之吴茱萸汤，故能收效。